Tema: Preeclampsia con criterios de severidad

Caso clínico:
Mujer de 27 años, G1P0, 33 semanas de gestación por FUM confiable. Acude por cefalea intensa persistente, fosfenos y dolor en epigastrio desde hace 8 horas. TA 168/112 mmHg en dos tomas separadas por 15 minutos. FC 96 lpm. Edema en extremidades inferiores ++. Proteinuria en tira reactiva +++. Laboratorio: plaquetas 130,000/mm^3, TGO 78 U/L, creatinina 1.3 mg/dL.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hipertensión gestacional
B) Preeclampsia sin criterios de severidad
C) Síndrome HELLP
D) *Preeclampsia con criterios de severidad**

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta inmediata según GPC mexicana?

A) Observación y control ambulatorio
B) Inducción inmediata sin estabilización
C) *Hospitalización, sulfato de magnesio y control antihipertensivo**
D) Solo antihipertensivo oral

Retroalimentación

La paciente cumple criterios de severidad: TA ≥160/110, datos neurológicos y epigastralgia. Según GPC mexicana de trastornos hipertensivos del embarazo y NOM-007, el manejo inicial es hospitalización, sulfato de magnesio para prevención de eclampsia y antihipertensivos IV (labetalol/hidralazina). La resolución del embarazo depende de estabilidad materno-fetal y edad gestacional.

Tema: Hemorragia del primer trimestre – Embarazo ectópico

Caso clínico:
Mujer de 30 años, G2P1, 7 semanas de amenorrea. Dolor abdominal tipo cólico en fosa iliaca derecha y sangrado transvaginal escaso. TA 100/60 mmHg, FC 108 lpm. USG transvaginal: útero vacío, masa anexial derecha de 3 cm, BHCG 2,500 mUI/mL.

Pregunta

¿Cuál es el manejo más adecuado según GPC mexicana?

A) Legrado uterino
B) *Metotrexato si cumple criterios**
C) Observación expectante
D) Histerectomía

Retroalimentación

Criterios para manejo médico: estabilidad hemodinámica, masa <3.5–4 cm, sin actividad cardiaca embrionaria y BHCG <5,000. La paciente cumple criterios. Según GPC mexicana de embarazo ectópico, el manejo de elección es metotrexato.

Tema: Hemorragia obstétrica – Atonía uterina

Caso clínico:
Paciente de 24 años, G1P1, parto eutócico hace 30 minutos. Presenta sangrado abundante. TA 90/50 mmHg, FC 120 lpm. Útero flácido a la palpación.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más probable?

A) Retención placentaria
B) Laceración cervical
C) *Atonía uterina**
D) Coagulopatía

Pregunta 2

Primer paso en manejo según NOM-007:

A) Histerectomía inmediata
B) *Masaje uterino bimanual y oxitocina IV**
C) Legrado uterino
D) Plasma fresco

Retroalimentación

La causa más frecuente de hemorragia obstétrica es atonía uterina. El manejo inicial es masaje uterino + uterotónicos (oxitocina primera línea).

Tema: Diabetes gestacional

Caso clínico:
Paciente de 32 años, 26 semanas de gestación. Glucosa en ayuno 98 mg/dL. Curva de tolerancia oral 75 g: 1h 185 mg/dL, 2h 160 mg/dL.

Pregunta

¿Cuál es el siguiente paso según NOM-015 y GPC mexicana?

A) Repetir estudio
B) Iniciar metformina

C) *Iniciar manejo nutricional y ejercicio, control glucémico**
D) Iniciar insulina inmediata

Retroalimentación

Con un valor alterado ya se diagnostica diabetes gestacional. El manejo inicial es dieta + ejercicio y monitoreo. Insulina si no hay control.

Tema: Placenta previa

Caso clínico:
Paciente de 35 años, G3P2, 34 semanas. Sangrado rojo brillante indoloro. Útero relajado, FCF normal.

Pregunta

Conducta correcta según GPC mexicana:

A) Tacto vaginal inmediato
B) Inducción del trabajo de parto
C) *Ultrasonido transvaginal y evitar tacto**
D) Alta domiciliaria

Retroalimentación

Sangrado rojo brillante indoloro sugiere placenta previa. Está contraindicado el tacto vaginal. Confirmación con USG.

Tema: Cáncer cervicouterino – Tamizaje

Caso clínico:
Mujer de 32 años, vida sexual activa desde los 18 años. Último Papanicolaou hace 4 años.

Pregunta

Según NOM-014, ¿cuál es la recomendación?

A) No requiere tamizaje
B) Solo VPH
C) *Citología cervical cada 3 años (25–34 años)**
D) Colposcopía directa

Retroalimentación

En mujeres de 25–34 años se realiza citología cada 3 años. VPH primario se recomienda ≥35 años.

Tema: Ruptura prematura de membranas (RPM)

Caso clínico:
Paciente 29 años, 35 semanas, salida de líquido claro transvaginal. Sin fiebre. FCF normal.

Pregunta

Conducta según GPC mexicana:

A) Alta domiciliaria
B) *Inducir trabajo de parto**
C) Manejo expectante hasta 37 semanas
D) Cesárea inmediata

Retroalimentación

RPM ≥34 semanas: se recomienda interrupción del embarazo por riesgo infeccioso.

Tema: Síndrome HELLP

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:
Mujer de 29 años, G2P1, 35 semanas de gestación. Antecedente de preeclampsia en embarazo previo. Acude por cefalea intensa, náusea, vómito y dolor en hipocondrio derecho de 24 horas de evolución. Refiere disminución de movimientos fetales. TA 162/108 mmHg, FC 102 lpm. Edema ++ en extremidades inferiores.
Laboratorio: Hb 11 g/dL, plaquetas 82,000/mm^3, TGO 145 U/L, TGP 132 U/L, DHL elevada, bilirrubina indirecta elevada, creatinina 1.4 mg/dL. EGO con proteinuria ++.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Preeclampsia sin datos de severidad
B) Hepatitis aguda viral
C) *Síndrome HELLP**
D) Colestasis intrahepática del embarazo

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta indicada según GPC mexicana?

A) Manejo ambulatorio y control en 48 horas
B) Corticoesteroides y continuar embarazo hasta 37 semanas
C) *Estabilización materna con sulfato de magnesio y resolución del embarazo**
D) Plasmaféresis inmediata

Retroalimentación

El síndrome HELLP se caracteriza por hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. Es una variante grave de preeclampsia. Según GPC mexicana de trastornos

hipertensivos, el manejo es estabilizar y resolver el embarazo independientemente de la edad gestacional si ≥34 semanas o si hay deterioro materno.

Tema: Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI)

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:
Paciente de 38 años, G4P3, 36 semanas de gestación, antecedente de hipertensión crónica. Acude por dolor abdominal súbito, intenso, continuo, acompañado de sangrado transvaginal oscuro en cantidad moderada. Refiere disminución de movimientos fetales. TA 150/95 mmHg. Útero hipertónico, doloroso a la palpación. FCF 90 lpm con desaceleraciones tardías persistentes.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Placenta previa
B) Ruptura uterina
C) *DPPNI**
D) Trabajo de parto pretérmino

Pregunta 2

Conducta inmediata:

A) Tacto vaginal para valorar dilatación
B) Manejo expectante
C) *Cesárea urgente**
D) Inducción con oxitocina

Retroalimentación

El DPPNI cursa con dolor abdominal + sangrado oscuro + hipertonía uterina. Con compromiso fetal se indica resolución inmediata por cesárea. Está basado en GPC mexicana de hemorragia obstétrica.

Tema: Corioamnionitis

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:
Mujer de 24 años, G1P0, 32 semanas de gestación. Antecedente de ruptura prematura de membranas hace 36 horas. Presenta fiebre de 38.7°C, taquicardia materna (110 lpm) y fetal (170 lpm), dolor uterino a la palpación y líquido amniótico fétido.

Pregunta

¿Cuál es el manejo indicado según GPC mexicana?

A) Manejo expectante hasta completar esquema de esteroides
B) Antibiótico ambulatorio
C) *Antibióticos IV de amplio espectro y resolución del embarazo**
D) Solo inducción sin antibiótico

Retroalimentación

La corioamnionitis es indicación de interrupción del embarazo más antibióticos IV (ampicilina + gentamicina según lineamientos). No debe prolongarse el embarazo por riesgo de sepsis materno-fetal.

Tema: Eclampsia

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:
Paciente de 19 años, G1, 30 semanas de gestación. Sin control prenatal. Presenta crisis convulsiva tónico-clónica generalizada en domicilio. Al ingreso: TA 170/115 mmHg, confusa, edema generalizado. Proteinuria +++.

Pregunta 1

¿Cuál es el fármaco de elección inicial?

A) Diazepam
B) Fenitoína
C) *Sulfato de magnesio**
D) Levetiracetam

Pregunta 2

Después de estabilizar a la paciente, ¿cuál es la conducta?

A) Continuar embarazo hasta 37 semanas
B) Alta domiciliaria
C) *Interrumpir el embarazo una vez estabilizada**
D) Solo control antihipertensivo

Retroalimentación

El tratamiento de elección para prevenir recurrencia de convulsiones es sulfato de magnesio. Toda eclampsia es indicación de resolución del embarazo tras estabilización materna.

Tema: Sepsis puerperal

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:
Paciente de 31 años, G2P2, 5 días post cesárea por sufrimiento fetal. Refiere fiebre de 39°C, malestar general y dolor hipogástrico. TA 95/60 mmHg, FC 120 lpm. Útero subinvolucionado y doloroso, loquios fétidos.

Pregunta

¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A) Antipiréticos y observación
B) *Antibióticos IV de amplio espectro y reanimación hídrica**
C) Legrado uterino inmediato
D) Alta con antibiótico oral

Retroalimentación

Cuadro compatible con endometritis puerperal complicada. Manejo hospitalario con antibióticos IV de amplio espectro según GPC mexicana y criterios de sepsis.

Tema: Distocia de hombros

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:
Mujer de 34 años, G2P1, antecedente de diabetes gestacional. Producto macrosómico estimado en 4,200 g. Durante el parto vaginal, tras la salida de la cabeza fetal, esta retrae contra el periné (signo de la tortuga). No progresa el descenso.

Pregunta

¿Cuál es la primera maniobra indicada?

A) Fórceps
B) Cesárea inmediata
C) *Maniobra de McRoberts**
D) Maniobra de Kristeller

Retroalimentación

La maniobra inicial en distocia de hombros es McRoberts (flexión de muslos sobre abdomen). Está contraindicada la presión fundica.

Tema: Hemorragias del primer trimestre

Subtema: Aborto incompleto

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:
Mujer de 26 años, G2P0A1, 10 semanas por FUM confiable. Acude por sangrado transvaginal abundante de 12 horas de evolución, acompañado de cólico hipogástrico intenso y expulsión de coágulos. Refiere que hace 3 días inició con manchado escaso. TA 100/65 mmHg, FC 105 lpm. A la exploración ginecológica: cérvix dilatado 2 cm, restos ovulares visibles en canal cervical. USG transvaginal: cavidad uterina con material ecogénico heterogéneo, sin saco gestacional íntegro.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Amenaza de aborto
B) Aborto diferido
C) *Aborto incompleto**
D) Embarazo ectópico

Pregunta 2

Según GPC mexicana de aborto espontáneo, ¿cuál es el manejo más adecuado?

A) Manejo expectante obligatorio
B) Antibiótico oral y alta
C) *Evacuación uterina (AMEU o legrado) según condiciones clínicas**
D) Histerectomía

Retroalimentación

El aborto incompleto se caracteriza por sangrado, dolor, cérvix dilatado y restos intrauterinos. Según GPC mexicana, el manejo puede ser médico o quirúrgico; sin embargo, ante sangrado abundante o compromiso hemodinámico, la evacuación uterina es el tratamiento indicado.

Tema: Hemorragias del primer trimestre

Subtema: Enfermedad trofoblástica gestacional

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:
Paciente de 19 años, G1, 12 semanas de amenorrea. Presenta sangrado transvaginal intermitente, náusea y vómito incoercible. Refiere expulsión de vesículas. TA 140/90 mmHg. Útero aumentado de tamaño mayor al esperado para edad gestacional. BHCG 250,000 mUI/mL. USG: patrón en “tormenta de nieve” sin embrión visible.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Aborto retenido
B) Embarazo múltiple
C) *Mola hidatiforme completa**
D) Embarazo ectópico

Pregunta 2

Conducta inicial según GPC mexicana:

A) Metotrexato inmediato
B) *Aspiración uterina y seguimiento con BHCG seriada**
C) Histerectomía en todas las pacientes
D) Observación

Retroalimentación

La mola completa cursa con BHCG muy elevada, ausencia de embrión y patrón ecográfico típico. El manejo es evacuación uterina por aspiración y seguimiento estrecho con BHCG para detectar enfermedad persistente.

Tema: Hemorragias del segundo y tercer trimestre

Subtema: Acretismo placentario

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:
Mujer de 37 años, G4P3, antecedente de 3 cesáreas previas. 35 semanas de gestación. USG reporta placenta previa oclusiva total con múltiples lagunas vasculares y pérdida del espacio retroplacentario. No presenta sangrado activo.

Pregunta

¿Cuál es la conducta recomendada según GPC mexicana?

A) Inducción del trabajo de parto
B) Cesárea convencional con intento de desprendimiento placentario
C) *Cesárea programada con equipo multidisciplinario y probable histerectomía obstétrica**
D) Manejo ambulatorio hasta inicio de trabajo de parto

Retroalimentación

Placenta previa + cesáreas previas aumenta riesgo de acretismo. El manejo es cesárea programada en hospital de tercer nivel, evitando intentar desprender la placenta por riesgo de hemorragia masiva.

Tema: Patología del embarazo

Subtema: Colestasis intrahepática del embarazo

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:
Paciente de 30 años, G2P1, 33 semanas. Refiere prurito intenso predominante en palmas y plantas, sin lesiones cutáneas visibles. No dolor abdominal ni fiebre. TA normal. Laboratorio: bilirrubina normal, elevación leve de TGO/TGP, ácidos biliares elevados.

Pregunta

¿Cuál es el manejo indicado?

A) Antihistamínicos y vigilancia
B) Corticoesteroides sistémicos
C) *Ácido ursodesoxicólico y programar interrupción a las 37 semanas**
D) Cesárea inmediata

Retroalimentación

La colestasis intrahepática aumenta riesgo de muerte fetal intrauterina. El manejo es ácido ursodesoxicólico y programación de interrupción alrededor de las 37 semanas.

Tema: Patología del trabajo de parto

Subtema: Inducción del trabajo de parto

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:
Paciente de 28 años, G1, 41 semanas de gestación. Sin trabajo de parto. Perfil biofísico 6/10 por disminución de líquido amniótico. Cérvix posterior, cerrado, 30% borramiento, Bishop 3.

Pregunta 1

¿Cuál es el método inicial recomendado?

A) Oxitocina directa
B) Cesárea inmediata
C) *Maduración cervical con prostaglandinas**
D) Maniobra de Hamilton

Pregunta 2

¿Por qué no se inicia oxitocina directamente?

A) Está contraindicada en embarazo postérmino
B) Produce sufrimiento fetal inmediato
C) *Bishop desfavorable requiere maduración previa**
D) Solo se usa en multíparas

Retroalimentación

Con Bishop <6 se recomienda maduración cervical previa con prostaglandinas antes de iniciar oxitocina, según GPC mexicana de inducción.

Tema: Patología puerperal

Subtema: Hemorragia obstétrica secundaria

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:
Mujer de 22 años, 10 días post parto eutócico. Acude por sangrado transvaginal abundante súbito, acompañado de mareo. TA 95/60 mmHg. USG muestra restos retenidos intrauterinos.

Pregunta

¿Cuál es el manejo indicado?

A) Observación
B) Uterotónicos exclusivamente

C) *Evacuación uterina y antibióticos si se sospecha infección**
D) Histerectomía inmediata

Retroalimentación

La hemorragia puerperal secundaria suele asociarse a restos placentarios retenidos. El manejo es evacuación uterina bajo cobertura antibiótica.

Tema: Estados hipertensivos del embarazo

Subtema: Preeclampsia sin criterios de severidad

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Mujer de 31 años, G2P1, 34 semanas de gestación por FUM confiable y corroborada por ultrasonido del primer trimestre. Antecedente de obesidad grado I (IMC 32 kg/m^2) y madre con antecedente de preeclampsia. Acude a consulta por cefalea leve intermitente y edema progresivo en extremidades inferiores desde hace 1 semana. Niega fosfenos, acúfenos o dolor epigástrico.

Signos vitales: TA 148/94 mmHg en primera toma y 150/96 mmHg 20 minutos después. FC 88 lpm. FR 18 rpm. Temperatura 36.7°C.
Altura uterina acorde a edad gestacional. FCF 145 lpm, reactiva.
Laboratorio: Hb 12 g/dL, plaquetas 190,000/mm^3, TGO/TGP normales, creatinina 0.8 mg/dL. EGO con proteinuria ++. Relación proteína/creatinina 0.5.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hipertensión crónica
B) Hipertensión gestacional
*C) Preeclampsia sin criterios de severidad
D) Preeclampsia con criterios de severidad

Pregunta 2

Según la GPC mexicana de trastornos hipertensivos del embarazo, ¿cuál es la conducta adecuada?

A) Interrupción inmediata del embarazo
*B) Manejo expectante con vigilancia materno-fetal estrecha hasta las 37 semanas
C) Alta domiciliaria sin seguimiento
D) Iniciar sulfato de magnesio de forma rutinaria

Retroalimentación

La paciente cumple criterios de preeclampsia (TA ≥140/90 + proteinuria) pero no tiene datos de severidad (no plaquetopenia, no elevación de enzimas hepáticas, no síntomas neurológicos graves). Según la GPC mexicana y NOM-007, el manejo es expectante con vigilancia estrecha hasta las 37 semanas, momento en que se recomienda la interrupción.

Tema: Hemorragias del segundo y tercer trimestre

Subtema: Vasa previa

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 33 años, G3P2, 36 semanas de gestación. Embarazo con diagnóstico previo de placenta bilobulada identificado en ultrasonido estructural. Acude a urgencias por sangrado transvaginal rojo brillante posterior a ruptura espontánea de membranas. Niega dolor abdominal. A la exploración: útero relajado, no doloroso. TA 110/70 mmHg. FC 92 lpm.

En monitor fetal se documenta bradicardia fetal sostenida de 80 lpm. El sangrado continúa en pequeña cantidad. No hay datos de choque materno.

Pregunta

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Placenta previa
B) DPPNI
*C) Vasa previa
D) Ruptura uterina

Pregunta

¿Cuál es la conducta inmediata indicada?

A) Manejo expectante
B) Inducción del trabajo de parto
*C) Cesárea urgente inmediata
D) Tacto vaginal para valorar dilatación

Retroalimentación

La vasa previa se sospecha ante sangrado rojo brillante tras ruptura de membranas con bradicardia fetal y estabilidad materna. La hemorragia es fetal. Es una urgencia obstétrica que requiere cesárea inmediata.

Tema: Parto pretérmino

Subtema: Amenaza de parto pretérmino (<34 semanas)

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Mujer de 24 años, G1, 31 semanas de gestación. Refiere contracciones uterinas regulares cada 8 minutos desde hace 4 horas, acompañadas de sensación de presión pélvica. Niega salida de líquido o sangrado. Control prenatal adecuado.

Signos vitales normales. A la exploración obstétrica: dinámica uterina regular, 3 contracciones en 10 minutos. Tacto vaginal: cérvix 2 cm de dilatación, 50% borramiento,

membranas íntegras. USG transvaginal con longitud cervical de 20 mm. FCF 150 lpm reactiva.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Trabajo de parto activo
*B) Amenaza de parto pretérmino
C) Falso trabajo de parto
D) RPM pretérmino

Pregunta 2

Según GPC mexicana, ¿cuál es el manejo indicado?

A) Alta domiciliaria
B) Inducción inmediata
*C) Tocolisis + esquema de maduración pulmonar con corticoesteroides
D) Cesárea inmediata

Retroalimentación

Entre 24 y 33.6 semanas, con cambios cervicales y dinámica uterina, se indica tocolisis (si no hay contraindicación) y corticoesteroides para maduración pulmonar fetal. Esto reduce morbimortalidad neonatal.

Tema: Patología del trabajo de parto

Subtema: Ruptura uterina

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 35 años, G4P3, antecedente de cesárea segmentaria hace 2 años. Cursa embarazo de 39 semanas. Se encuentra en trabajo de parto inducido con oxitocina por embarazo postérmino. Después de 6 horas presenta dolor abdominal súbito, intenso, persistente, diferente a las contracciones. Se documenta pérdida de la estación fetal previamente descendida y alteración súbita en FCF con desaceleraciones prolongadas. TA 90/60 mmHg, FC 120 lpm. Abdomen doloroso, palpación fácil de partes fetales.

Pregunta

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) DPPNI
B) Distocia dinámica
*C) Ruptura uterina
D) Placenta previa

Pregunta

Conducta inmediata:

A) Suspender oxitocina y observar
B) Inducción con prostaglandinas
*C) Laparotomía urgente y resolución quirúrgica
D) Manejo expectante

Retroalimentación

Ante antecedente de cesárea y datos de choque + sufrimiento fetal + pérdida de estación, se debe sospechar ruptura uterina. Es una emergencia quirúrgica inmediata.

Tema: Patología del embarazo

Subtema: Diabetes gestacional con falla a manejo nutricional

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Mujer de 36 años, G3P1A1, 29 semanas de gestación. Antecedente de macrosomía fetal en embarazo previo (4,250 g). IMC pregestacional 31 kg/m^2. En tamizaje con CTGO de 75 g a las 24 semanas presentó: ayuno 97 mg/dL, 1h 189 mg/dL, 2h 162 mg/dL, por lo que se diagnosticó diabetes gestacional.

Se inició plan nutricional individualizado y recomendación de ejercicio aeróbico moderado 30 minutos diarios. La paciente refiere apego adecuado. En controles domiciliarios reporta las siguientes cifras en la última semana:

- Ayuno: 102–108 mg/dL
- 1 hora postprandial: 165–185 mg/dL

USG obstétrico: feto único vivo, biometría en percentil 90, líquido amniótico normal. No datos de restricción ni polihidramnios.

Pregunta 1

¿Cuál es la meta glucémica según lineamientos mexicanos?

A) Ayuno <110 mg/dL y postprandial <200 mg/dL
B) Ayuno <100 mg/dL y postprandial <180 mg/dL
C) Ayuno <95 mg/dL y postprandial <140 mg/dL *
D) Ayuno <120 mg/dL y postprandial <160 mg/dL

Pregunta 2

¿Cuál es el siguiente paso en el manejo?

A) Continuar solo dieta 2 semanas más
B) Iniciar metformina como primera línea obligatoria
C) Programar interrupción inmediata
D) Iniciar insulinoterapia *

Retroalimentación

Según NOM-015 y GPC mexicana de diabetes en el embarazo, si no se alcanzan metas con manejo nutricional tras 1–2 semanas, se debe iniciar insulina. Las metas son ayuno <95 mg/dL y 1h postprandial <140 mg/dL.

Tema: Hemorragias del segundo y tercer trimestre

Subtema: Placenta previa oclusiva total

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 34 años, G2P1, 32 semanas de gestación. Antecedente de cesárea hace 3 años. Consulta por sangrado transvaginal rojo brillante en moderada cantidad, sin dolor abdominal. Refiere episodio similar hace 2 semanas que cedió espontáneamente.

Signos vitales: TA 110/70 mmHg, FC 90 lpm. Útero relajado, no doloroso. FCF 145 lpm reactiva. USG transvaginal confirma placenta previa oclusiva total. Hemoglobina 10.8 g/dL.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Realizar tacto vaginal para valorar dilatación
B) Inducir trabajo de parto
C) Hospitalización y vigilancia expectante *
D) Cesárea urgente inmediata

Pregunta 2

¿En qué momento debe programarse la interrupción si no hay nuevo sangrado?

A) 34 semanas
B) 35 semanas
C) 36–37 semanas *
D) 40 semanas

Retroalimentación

En placenta previa estable y <36–37 semanas se recomienda manejo expectante hospitalario. La interrupción programada se realiza alrededor de 36–37 semanas si no hay sangrado masivo.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Trabajo de parto prolongado por distocia dinámica (hipodinamia)

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Mujer de 22 años, G1, 39 semanas. Inició trabajo de parto hace 14 horas. Membranas rotas hace 8 horas. Dinámica uterina irregular, 1–2 contracciones en 10 minutos, de baja intensidad. Tacto vaginal actual: 4 cm de dilatación, 70% borramiento, presentación cefálica en -2 estación.

No fiebre. FCF 140 lpm reactiva. Pelvis clínica adecuada.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Trabajo de parto normal
B) Distocia por desproporción cefalopélvica
C) Distocia dinámica por hiperdinamia
D) Distocia dinámica por hipodinamia *

Pregunta 2

Conducta indicada:

A) Cesárea inmediata
B) Manejo expectante indefinido
C) Administración de prostaglandinas
D) Inicio o ajuste de oxitocina IV con vigilancia estrecha *

Retroalimentación

La hipodinamia uterina se caracteriza por contracciones insuficientes que no permiten progresión cervical. El manejo es estimulación con oxitocina bajo monitoreo fetal continuo.

Tema: Patología puerperal

Subtema: Choque hipovolémico secundario a hemorragia obstétrica primaria

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 28 años, G2P2, parto eutócico hace 20 minutos. Presenta sangrado abundante continuo estimado en 1,200 mL. Se encuentra pálida, diaforética, con TA 80/50 mmHg, FC 130 lpm, FR 24 rpm. Útero flácido a la palpación. No desgarros evidentes.

Hb previa al parto 12 g/dL.

Pregunta 1

¿Cuál es el grado de choque más probable?

A) Grado I
B) Grado II
C) Grado III *
D) Grado IV

Pregunta 2

¿Cuál es la prioridad inicial en el manejo?

A) Legrado uterino inmediato
B) Histerectomía inmediata
C) Reposición hídrica agresiva con cristaloides y activación de protocolo de hemorragia masiva *
D) Antibióticos profilácticos

Retroalimentación

Pérdida >1,000 mL con hipotensión y taquicardia corresponde a choque grado III. Se debe iniciar reanimación hídrica inmediata y protocolo de hemorragia obstétrica, además de masaje uterino y uterotónicos.

Tema: Estados hipertensivos del embarazo

Subtema: Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Mujer de 38 años, G3P2, 32 semanas de gestación. Antecedente de hipertensión arterial diagnosticada hace 4 años, en tratamiento con metildopa desde el inicio del embarazo. En controles previos mantenía cifras promedio de 135/85 mmHg sin proteinuria.

Acude por cefalea progresiva de 48 horas, edema facial marcado y disminución de movimientos fetales. TA 168/110 mmHg en dos tomas separadas por 20 minutos. FC 96 lpm. Reflejos osteotendinosos ++ con clonus leve.

Laboratorio:

- Plaquetas 145,000/mm^3
- Creatinina 1.2 mg/dL (previa 0.7 mg/dL)
- TGO 85 U/L
- Relación proteína/creatinina 0.8

USG obstétrico: feto con peso estimado en percentil 8 para edad gestacional, líquido amniótico disminuido.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hipertensión crónica descontrolada
B) Preeclampsia sin datos de severidad
C) Hipertensión gestacional
D) Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada *

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta adecuada según GPC mexicana?

A) Ajustar antihipertensivo y continuar embarazo hasta 37 semanas
B) Alta domiciliaria con vigilancia semanal
C) Hospitalización, sulfato de magnesio y valorar interrupción según estabilidad materno-fetal *
D) Solo vigilancia fetal ambulatoria

Retroalimentación

En paciente con hipertensión crónica que desarrolla proteinuria nueva y datos de severidad se diagnostica preeclampsia sobreagregada. El manejo requiere hospitalización, prevención de eclampsia y valoración para interrupción según evolución.

Tema: Parto pretérmino

Subtema: Ruptura prematura de membranas pretérmino (<34 semanas)

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 27 años, G2P1, 30 semanas de gestación. Refiere salida súbita de líquido claro transvaginal hace 3 horas. Niega contracciones. Sin fiebre ni dolor abdominal.

Exploración con espéculo: salida de líquido a través de OCE, prueba de cristalización positiva.
TA 110/70 mmHg. FC 88 lpm. Temperatura 36.8°C.
Biometría hemática normal. FCF 148 lpm reactiva. USG con líquido amniótico disminuido, feto acorde a edad gestacional.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta adecuada?

A) Inducir trabajo de parto de inmediato
B) Alta domiciliaria
C) Cesárea urgente
D) Manejo expectante hospitalario con antibióticos y esquema de maduración pulmonar *

Pregunta 2

¿Qué antibiótico forma parte del esquema recomendado para prolongar latencia?

A) Ciprofloxacino
B) Ceftriaxona
C) Ampicilina *
D) Metronidazol

Retroalimentación

En RPM pretérmino <34 semanas sin datos de infección, se recomienda manejo expectante hospitalario, antibióticos para prolongar latencia y corticoesteroides para maduración pulmonar. La ampicilina forma parte del esquema inicial.

Tema: Embarazo múltiple

Subtema: Síndrome de transfusión feto-fetal

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 29 años, G1, 26 semanas de gestación gemelar monocoriónica biamniótica. En ultrasonido de control se observa un feto con polihidramnios severo y vejiga distendida, y el otro con oligohidramnios severo y vejiga colapsada. Diferencia significativa en peso estimado fetal. Doppler umbilical con alteraciones en el feto donador.

La paciente refiere aumento rápido del perímetro abdominal y disnea leve.

Pregunta

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Restricción selectiva del crecimiento
B) Embarazo gemelar bicorial
C) Síndrome de transfusión feto-fetal *
D) Corioamnionitis

Pregunta

¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Inducción inmediata
B) Amniocentesis evacuadora aislada
C) Manejo expectante
D) Fotocoagulación láser de anastomosis placentarias *

Retroalimentación

En embarazo monocoriónico con discordancia de líquido amniótico y compromiso hemodinámico, el tratamiento definitivo es la ablación láser de las anastomosis placentarias.

Tema: Patología del trabajo de parto

Subtema: Sufrimiento fetal agudo intraparto

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Mujer de 25 años, G1, 40 semanas. Trabajo de parto activo con 7 cm de dilatación. Monitoreo electrónico fetal muestra desaceleraciones tardías recurrentes en más del 50% de las contracciones durante 30 minutos, variabilidad mínima y ausencia de aceleraciones.

TA materna normal. No fiebre. Líquido amniótico con meconio espeso.

Pregunta 1

¿Qué categoría del monitoreo fetal corresponde?

A) Categoría I
B) Categoría II
C) Categoría III *
D) Normal

Pregunta 2

Conducta inmediata:

A) Continuar vigilancia
B) Cambiar posición materna y esperar
C) Oxigenoterapia únicamente
D) Resolución inmediata del embarazo (cesárea si no es inminente parto vaginal) *

Retroalimentación

Patrón categoría III implica hipoxia fetal. Si no hay parto vaginal inminente, se debe proceder a resolución inmediata.

Tema: Patología del embarazo

Subtema: Oligohidramnios con restricción del crecimiento intrauterino

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 34 años, G2P1, 35 semanas. Control prenatal irregular. Refiere disminución de movimientos fetales en los últimos 2 días.

USG: índice de líquido amniótico 3 cm, peso estimado fetal en percentil 5, Doppler umbilical con aumento de resistencia. TA 150/95 mmHg. Proteinuria +.

Pregunta

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Manejo expectante hasta 37 semanas
B) Hidratación oral y alta
C) Inducción inmediata del trabajo de parto o cesárea según condiciones obstétricas *
D) Solo vigilancia semanal

Retroalimentación

Oligohidramnios severo con restricción y alteración Doppler sugiere compromiso fetal. Se recomienda interrupción del embarazo tras valoración integral.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Trabajo de parto fisiológico y análisis con partograma

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 23 años, G1, 39 semanas de gestación, sin comorbilidades. Inicia trabajo de parto espontáneo hace 10 horas. Membranas íntegras. A su ingreso presentaba 3 cm de dilatación, 70% de borramiento, presentación cefálica en -2 estación.

Se inicia vigilancia con partograma. Después de 6 horas en fase activa, se documenta progresión de 4 cm a 5 cm únicamente. Contracciones 3 en 10 minutos, intensidad moderada. FCF 145 lpm reactiva. Pelvis clínica adecuada. No fiebre.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Trabajo de parto normal
B) Fase latente prolongada
C) Arresto secundario de dilatación
D) Progreso inadecuado en fase activa *

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta recomendada según GPC mexicana?

A) Cesárea inmediata
B) Manejo expectante indefinido
C) Amniotomía y conducción con oxitocina bajo vigilancia *
D) Alta domiciliaria

Retroalimentación

En fase activa debe haber progresión cervical adecuada. Si no la hay y no existe desproporción cefalopélvica, se recomienda conducción con oxitocina y/o amniotomía bajo monitoreo continuo.

Tema: Complicaciones obstétricas graves

Subtema: Embolia de líquido amniótico

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 35 años, G2P1, 40 semanas, en trabajo de parto activo con 8 cm de dilatación. Súbitamente presenta disnea intensa, cianosis, hipotensión (TA 70/40 mmHg), taquicardia 130 lpm y pérdida del estado de alerta. Se documenta bradicardia fetal severa. Posteriormente desarrolla sangrado incoercible por sitio de venopunción y datos de coagulopatía.

No antecedente de cardiopatía ni alergias.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tromboembolia pulmonar
B) Ruptura uterina
C) Anafilaxia
D) Embolia de líquido amniótico *

Pregunta 2

¿Cuál es la prioridad en el manejo?

A) Heparina inmediata
B) Antihistamínicos
C) Soporte vital avanzado, manejo en UCI y resolución obstétrica urgente *
D) Manejo expectante

Retroalimentación

La embolia de líquido amniótico se presenta con colapso cardiovascular súbito, hipoxia y coagulopatía. El manejo es soporte vital avanzado inmediato y resolución obstétrica si la paciente no ha parido.

Tema: Patología puerperal

Subtema: Inversión uterina

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 20 años, G1P1, parto eutócico hace 10 minutos. Durante el alumbramiento se realiza tracción excesiva del cordón umbilical sin signos claros de desprendimiento placentario. Inmediatamente presenta dolor intenso, hemorragia masiva y choque hipovolémico. A la exploración no se palpa fondo uterino en abdomen y se observa masa roja protruyendo por vagina.

TA 80/40 mmHg, FC 140 lpm.

Pregunta

¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A) Histerectomía inmediata
B) Legrado uterino
C) Administración exclusiva de uterotónicos
D) Reposición manual inmediata del útero y reanimación hemodinámica *

Retroalimentación

La inversión uterina es una emergencia obstétrica. La prioridad es reposicionar manualmente el útero de inmediato y estabilizar hemodinámicamente a la paciente.

Tema: Patología del embarazo

Subtema: Polihidramnios asociado a diabetes

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 33 años, G2P1, 34 semanas, con diagnóstico de diabetes gestacional en tratamiento irregular. Refiere disnea progresiva y sensación de distensión abdominal excesiva.

USG: índice de líquido amniótico 28 cm, feto macrosómico estimado en percentil 95. Doppler normal. No contracciones. TA normal.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más probable del polihidramnios?

A) Atresia esofágica
B) Infección intrauterina
C) Diabetes gestacional mal controlada *
D) Insuficiencia placentaria

Pregunta 2

¿Cuál es la principal complicación obstétrica asociada?

A) Oligohidramnios
B) Restricción del crecimiento
C) Desprendimiento prematuro de placenta
D) Parto pretérmino *

Retroalimentación

La hiperglucemia fetal genera poliuria osmótica, produciendo polihidramnios. Se asocia a riesgo aumentado de parto pretérmino y distocia por macrosomía.

Tema: Cardiopatías en el embarazo

Subtema: Miocardiopatía periparto

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 30 años, G3P3, 2 semanas postparto. Acude por disnea progresiva, ortopnea y edema en extremidades inferiores. Niega fiebre. TA 100/60 mmHg, FC 115 lpm. Estertores crepitantes bibasales. Ingurgitación yugular.

Ecocardiograma: fracción de eyección 35%, dilatación ventricular izquierda. No antecedentes cardiacos previos.

Pregunta

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tromboembolia pulmonar
B) Neumonía
C) Miocardiopatía periparto *
D) Crisis hipertensiva

Pregunta

¿Cuál es parte fundamental del tratamiento?

A) Betabloqueador contraindicado
B) Suspender lactancia obligatoriamente
C) Diuréticos y tratamiento estándar de insuficiencia cardiaca ajustado al puerperio *
D) Solo reposo

Retroalimentación

La miocardiopatía periparto ocurre en el último mes de embarazo o primeros meses postparto con disfunción sistólica. El manejo es similar al de insuficiencia cardiaca, considerando seguridad en lactancia.

Tema: Control prenatal

Subtema: Isoinmunización Rh y profilaxis anti-D

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Mujer de 27 años, G2P1, 28 semanas de gestación. Grupo sanguíneo O Rh negativo. Su primer embarazo terminó en parto eutócico hace 3 años; el recién nacido fue Rh positivo. La paciente refiere que no recuerda haber recibido alguna inyección posterior al parto.

En el embarazo actual, el Coombs indirecto al inicio fue negativo. En la consulta actual se repite Coombs indirecto y continúa negativo. No presenta sangrado ni procedimientos invasivos recientes. Ultrasonido obstétrico normal, sin datos de hidrops fetal.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta indicada en este momento?

A) No hacer nada hasta el parto
B) Aplicar gammaglobulina anti-D solo si el recién nacido es Rh positivo
C) Aplicar gammaglobulina anti-D dentro de las primeras 72 horas posparto únicamente
D) Administrar inmunoglobulina anti-D profiláctica a las 28 semanas *

Pregunta 2

¿En cuál de las siguientes situaciones también está indicada la aplicación de anti-D durante el embarazo?

A) Hipertensión gestacional
B) Diabetes gestacional
C) Procedimiento invasivo como amniocentesis *
D) Trabajo de parto fisiológico sin complicaciones

Retroalimentación

Según NOM-007 y GPC mexicana, toda paciente Rh negativa no sensibilizada debe recibir profilaxis con inmunoglobulina anti-D a las 28 semanas y dentro de las 72 horas posparto si el recién nacido es Rh positivo. También está indicada ante eventos que puedan generar hemorragia feto-materna (amniocentesis, sangrado, trauma abdominal).

Tema: Patología del embarazo

Subtema: Restricción del crecimiento intrauterino con Doppler severamente alterado

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 35 años, G2P1, 33 semanas de gestación. Antecedente de preeclampsia en embarazo previo. Acude por disminución de movimientos fetales.

TA 150/100 mmHg. Proteinuria +++.
Ultrasonido obstétrico: peso fetal estimado en percentil 3, índice de líquido amniótico 4 cm. Doppler de arteria umbilical con flujo diastólico ausente persistente. Perfil biofísico 6/10.

Pregunta

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Manejo expectante hasta 37 semanas
B) Hidratación materna y control en una semana
C) Administración de tocolíticos
D) Interrupción del embarazo tras estabilización materna *

Retroalimentación

La ausencia persistente de flujo diastólico en arteria umbilical es un dato de compromiso fetal severo. Según GPC mexicana, está indicada la interrupción del embarazo tras valorar estabilidad materno-fetal.

Tema: Patología tromboembólica en el embarazo

Subtema: Trombosis venosa profunda

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Mujer de 30 años, G2P1, 29 semanas de gestación. Obesidad grado II. Refiere dolor y aumento de volumen en pierna izquierda desde hace 48 horas. Niega fiebre. A la exploración: edema asimétrico, aumento de temperatura local, dolor a la palpación en trayecto venoso profundo. Signos vitales estables.

Ultrasonido Doppler confirma trombosis venosa profunda femoropoplítea izquierda.

Pregunta 1

¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Warfarina
B) Rivaroxabán
C) Heparina de bajo peso molecular *
D) Aspirina

Pregunta 2

¿Por qué está contraindicada la warfarina en el embarazo?

A) No es efectiva
B) Aumenta riesgo de hemorragia materna exclusivamente
C) Produce hipertensión
D) Es teratogénica y atraviesa la placenta *

Retroalimentación

La heparina de bajo peso molecular es el tratamiento de elección en embarazo. Los anticoagulantes antagonistas de vitamina K son teratogénicos y atraviesan la placenta.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Macrosomía fetal

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 38 años, G4P3, 39 semanas. Diabetes gestacional con control irregular. Ultrasonido con peso fetal estimado de 4,450 g. Pelvis clínica aparentemente adecuada. No antecedente de cesárea previa.

Pregunta

¿Cuál es la recomendación según lineamientos mexicanos en sospecha de macrosomía ≥4,500 g en madre diabética?

A) Intentar parto vaginal sin precauciones
B) Inducir trabajo de parto inmediatamente
C) Cesárea electiva programada *
D) Manejo expectante hasta 41 semanas

Retroalimentación

En madres diabéticas con peso estimado ≥4,500 g se recomienda considerar cesárea electiva para disminuir riesgo de distocia de hombros.

Tema: Marco normativo en atención obstétrica

Subtema: Violencia obstétrica (NOM-007)

Grado de dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 19 años, G1, en trabajo de parto activo. Refiere que durante la atención médica se le realizaron múltiples tactos vaginales por diferentes personas sin explicación ni consentimiento. Además, se le practicó episiotomía sin indicación clínica clara y sin informarle previamente.

No hubo complicaciones médicas, pero la paciente presenta angustia significativa posterior al evento.

Pregunta

Según la NOM-007 y lineamientos nacionales, lo ocurrido se clasifica como:

A) Procedimiento estándar sin relevancia legal
B) Complicación obstétrica inevitable
C) Violencia obstétrica por prácticas invasivas sin consentimiento informado *
D) Mala praxis exclusivamente penal

Retroalimentación

La NOM-007 establece la obligación de brindar atención digna, respetuosa y con consentimiento informado. Procedimientos innecesarios o sin información adecuada constituyen violencia obstétrica.

Tema: Trastornos hipertensivos del embarazo

Subtema: Eclampsia y manejo de toxicidad por sulfato de magnesio

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 24 años, G1, 36 semanas de gestación. Acude por cefalea intensa occipital, fosfenos y dolor en epigastrio. TA 170/110 mmHg. Proteinuria +++. Durante la valoración presenta crisis convulsiva tónico-clónica generalizada de 1 minuto de duración.

Se inicia manejo con sulfato de magnesio esquema de Pritchard. Dos horas después, la paciente se encuentra somnolienta, con frecuencia respiratoria de 8 rpm, reflejos osteotendinosos abolidos y diuresis de 15 mL/h en las últimas 2 horas.

Pregunta 1

¿Cuál es la complicación más probable?

A) Evento vascular cerebral
B) Toxicidad por sulfato de magnesio *
C) Síndrome HELLP
D) Hipoglucemia severa

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Administrar diazepam
B) Suspender magnesio y administrar gluconato de calcio IV *
C) Iniciar ventilación no invasiva sin suspender magnesio
D) Administrar más sulfato de magnesio

Retroalimentación

La depresión respiratoria y abolición de reflejos son datos clásicos de toxicidad por magnesio. El antídoto es gluconato de calcio IV. Debe suspenderse inmediatamente la infusión.

Tema: Complicaciones hepáticas del embarazo

Subtema: Hígado graso agudo del embarazo

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 29 años, G2P1, 35 semanas. Refiere náusea persistente, vómitos, malestar general y dolor en hipocondrio derecho desde hace 4 días. TA 140/90 mmHg. No proteinuria significativa.

Laboratorios: AST 350 U/L, ALT 280 U/L, bilirrubina total 4.2 mg/dL, glucosa 52 mg/dL, plaquetas 140,000, creatinina 1.8 mg/dL, INR prolongado.

USG hepático sin datos de obstrucción biliar. No antecedente de hepatitis viral.

Pregunta

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Colestasis intrahepática del embarazo
B) Hepatitis viral aguda
C) Síndrome HELLP
D) Hígado graso agudo del embarazo *

Pregunta

¿Cuál es la conducta indicada?

A) Manejo expectante hasta 37 semanas
B) Administración de ácido ursodesoxicólico
C) Interrupción inmediata del embarazo tras estabilización materna *
D) Solo vigilancia en consulta externa

Retroalimentación

La hipoglucemia, alteración de coagulación y falla hepatorrenal sugieren hígado graso agudo. Es una emergencia obstétrica que requiere interrupción inmediata.

Tema: Hemorragias obstétricas

Subtema: Atonía uterina refractaria

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 32 años, G3P3, parto vaginal hace 30 minutos. Producto macrosómico de 4,200 g. Presenta sangrado abundante estimado en 1,200 mL. Útero blando a la palpación.

Se administra masaje uterino y oxitocina IV sin respuesta adecuada. Posteriormente se administran metilergonovina y misoprostol rectal sin mejoría significativa. Persiste hipotensión 85/50 mmHg.

Pregunta

¿Cuál es el siguiente paso en el manejo escalonado?

A) Legrado uterino inmediato
B) Colocación de balón de taponamiento uterino (Bakri) *
C) Alta hospitalaria
D) Esperar respuesta a uterotónicos

Retroalimentación

En atonía refractaria a uterotónicos, el siguiente paso es taponamiento uterino con balón. Si falla, se considera manejo quirúrgico (B-Lynch o histerectomía).

Tema: Patología hepática

Subtema: Colestasis intrahepática del embarazo

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 31 años, G2P1, 33 semanas. Refiere prurito intenso predominante en palmas y plantas, peor por la noche, sin lesiones cutáneas primarias. Niega fiebre.

Laboratorios: bilirrubinas normales, AST y ALT ligeramente elevadas, ácidos biliares séricos elevados. Perfil biofísico normal.

Pregunta 1

¿Cuál es el tratamiento farmacológico indicado?

A) Prednisona
B) Ácido ursodesoxicólico *
C) Vitamina K exclusivamente
D) Antihistamínicos como tratamiento definitivo

Pregunta 2

¿Cuál es la principal complicación fetal asociada?

A) Macrosomía
B) Restricción del crecimiento
C) Muerte fetal intrauterina *
D) Cardiopatía congénita

Retroalimentación

La colestasis se asocia a aumento de riesgo de muerte fetal súbita. Se recomienda considerar interrupción alrededor de las 37 semanas según evolución.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Inducción fallida

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 40 años, G2P1, 41 semanas. Bishop inicial 3 puntos. Se realiza maduración cervical con misoprostol y posteriormente oxitocina durante 18 horas con adecuada dinámica uterina documentada (4–5 contracciones en 10 minutos). Sin embargo, la dilatación permanece en 4 cm sin cambios durante 6 horas consecutivas.

FCF reactiva. Membranas rotas hace 10 horas.

Pregunta

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Trabajo de parto normal
B) Fase latente prolongada
C) Inducción fallida *
D) Distocia de hombros

Pregunta

¿Cuál es la conducta indicada?

A) Continuar oxitocina indefinidamente
B) Cesárea *
C) Alta domiciliaria
D) Repetir misoprostol

Retroalimentación

Se considera inducción fallida cuando no se logra progresión adecuada tras manejo correcto con dinámica efectiva. La conducta es cesárea.

Tema: Hemorragias del tercer trimestre

Subtema: Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI) severo

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 34 años, G3P2, 35 semanas de gestación. Antecedente de hipertensión crónica mal controlada. Acude a urgencias por dolor abdominal súbito, intenso, continuo, acompañado de sangrado transvaginal oscuro en cantidad moderada desde hace 1 hora. Refiere disminución marcada de movimientos fetales.

A la exploración: TA 90/60 mmHg, FC 120 lpm. Abdomen con hipertonía uterina, útero doloroso a la palpación, sin relajación entre contracciones. FCF 90 lpm sostenida.

Laboratorios: Hb 8.5 g/dL, fibrinógeno bajo, TP y TTP prolongados.

Pregunta

¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Inducción del trabajo de parto
B) Manejo expectante con vigilancia estrecha
C) Cesárea urgente tras estabilización materna *
D) Tocolisis

Retroalimentación

El DPPNI severo con compromiso materno-fetal requiere resolución inmediata del embarazo tras estabilización hemodinámica. Existe alto riesgo de CID.

Tema: Infecciones en el embarazo

Subtema: Corioamnionitis clínica

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 22 años, G1, 39 semanas. Ruptura de membranas desde hace 20 horas. Refiere fiebre y malestar general.

Exploración: TA 110/70 mmHg, FC 115 lpm, temperatura 38.7°C. Útero doloroso a la palpación. FCF 170 lpm. Líquido amniótico fétido. Leucocitosis 18,000.

Pregunta

¿Cuál es el manejo indicado?

A) Solo antipiréticos
B) Antibióticos IV de amplio espectro e interrupción del embarazo *
C) Manejo expectante
D) Cesárea inmediata sin antibióticos

Retroalimentación

La corioamnionitis requiere antibióticos IV y finalización del embarazo. La vía depende de condiciones obstétricas, no es cesárea obligatoria.

Tema: Emergencias obstétricas

Subtema: Ruptura uterina

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 30 años, G2P1, antecedente de cesárea segmentaria hace 2 años. 40 semanas, en trabajo de parto con oxitocina. Tras varias horas, presenta dolor abdominal súbito intenso, cese de contracciones y pérdida de la estación fetal.

Exploración: TA 85/50 mmHg, FC 130 lpm. FCF no detectable. Abdomen doloroso, palpación fácil de partes fetales.

Pregunta

¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Continuar oxitocina
B) Laparotomía exploradora urgente *
C) Tocolíticos
D) Vigilancia

Retroalimentación

La ruptura uterina es una emergencia vital. Se requiere laparotomía inmediata y resolución quirúrgica.

Tema: Anomalías placentarias

Subtema: Espectro de acretismo placentario

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 38 años, G4P3, dos cesáreas previas. USG a las 32 semanas muestra placenta anterior baja con múltiples lagunas vasculares y pérdida de la zona hipoecoica retroplacentaria. Doppler con hipervascularidad anormal.

Asintomática actualmente.

Pregunta

¿Cuál es el plan más adecuado?

A) Intentar parto vaginal
B) Cesárea programada con equipo multidisciplinario y probable histerectomía obstétrica *
C) Manejo expectante hasta inicio espontáneo
D) Inducción a las 37 semanas

Retroalimentación

El espectro de acretismo requiere cesárea programada en centro de tercer nivel, con alta probabilidad de histerectomía.

Tema: Hemorragias del tercer trimestre

Subtema: Vasa previa

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 29 años, G2P1, 36 semanas. Diagnóstico prenatal de inserción velamentosa del cordón con vasos fetales atravesando el orificio cervical interno. Acude por ruptura espontánea de membranas con sangrado rojo brillante inmediato. FCF 70 lpm.

Madre hemodinámicamente estable.

Pregunta

¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Vigilancia
B) Cesárea urgente *
C) Inducción del trabajo de parto
D) Reposición de líquidos únicamente

Retroalimentación

En vasa previa rota, el sangrado es fetal. La bradicardia fetal indica hipovolemia aguda fetal. Se requiere cesárea inmediata.

Tema: Hemorragias del tercer trimestre

Subtema: Placenta previa oclusiva total

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 33 años, G3P2, 34 semanas de gestación. Antecedente de una cesárea previa. Acude por sangrado transvaginal rojo brillante, abundante, de inicio súbito, indoloro, sin actividad uterina. Niega traumatismo. Refiere movimientos fetales normales.

A la exploración: TA 110/70 mmHg, FC 95 lpm. Abdomen sin dolor a la palpación, útero relajado. FCF 140 lpm reactiva.

Ultrasonido transvaginal reporta placenta que cubre completamente el orificio cervical interno.

Pregunta

¿Cuál es la conducta indicada?

A) Tacto vaginal para valorar dilatación
B) Inducción del trabajo de parto

C) Cesárea programada a las 36–37 semanas si estabilidad materno-fetal *
D) Manejo expectante hasta inicio espontáneo de trabajo de parto

Retroalimentación

La placenta previa oclusiva total contraindica el parto vaginal. El tacto vaginal está contraindicado por riesgo de hemorragia masiva.

Tema: Infecciones perinatales

Subtema: Ruptura prematura de membranas pretérmino (RPMPT)

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 26 años, G1, 32 semanas. Refiere salida de líquido claro abundante desde hace 4 horas. Sin fiebre ni dolor abdominal.

Exploración: TA 100/65 mmHg, T 36.8°C. Especuloscopía con salida de líquido claro por OCI. Prueba de cristalización positiva. FCF 145 lpm.

BH normal. Sin datos clínicos de infección.

Pregunta

¿Cuál es el manejo adecuado?

A) Inducción inmediata del parto
B) Manejo expectante con antibióticos, maduración pulmonar y vigilancia *
C) Cesárea urgente
D) Tocolíticos como única medida

Retroalimentación

En RPM pretérmino sin infección ni compromiso fetal, se recomienda manejo expectante con corticoesteroides y antibióticos para prolongar gestación.

Tema: Endocrinología obstétrica

Subtema: Diabetes gestacional mal controlada intraparto

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 29 años, G2P1, 39 semanas, diabetes gestacional en tratamiento con insulina. Durante trabajo de parto presenta glucosa capilar de 210 mg/dL.

Dinámica uterina adecuada. FCF normal.

Pregunta

¿Cuál es la meta de glucosa intraparto?

A) <200 mg/dL
B) 150–180 mg/dL
C) 70–110 mg/dL *
D) <250 mg/dL

Retroalimentación

Durante el trabajo de parto se recomienda mantener glucosa entre 70–110 mg/dL para reducir riesgo de hipoglucemia neonatal.

Tema: Complicaciones del puerperio

Subtema: Endometritis puerperal

Grado de dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 24 años, 4 días postcesárea. Presenta fiebre 38.5°C, dolor hipogástrico y loquios fétidos.

Exploración: útero doloroso a la palpación, subinvolucionado. Leucocitosis 17,000.

Pregunta

¿Cuál es el tratamiento indicado?

A) Antibiótico oral ambulatorio
B) Antibióticos IV de amplio espectro (clindamicina + gentamicina) *
C) Legrado inmediato
D) Solo antipiréticos

Retroalimentación

La endometritis puerperal requiere antibióticos IV de amplio espectro. La cesárea es factor de riesgo importante.

Tema: Patología hipertensiva

Subtema: Hipertensión gestacional vs preeclampsia

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 30 años, G1, 38 semanas. TA 150/95 mmHg en dos tomas separadas por 6 horas. No cefalea, no fosfenos. EGO sin proteinuria. Plaquetas normales, enzimas hepáticas normales.

Pregunta

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Preeclampsia sin datos de severidad
B) Hipertensión crónica
C) Hipertensión gestacional *
D) Síndrome HELLP

Retroalimentación

Hipertensión después de 20 semanas sin proteinuria ni datos de daño orgánico corresponde a hipertensión gestacional.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Prolapso de cordón umbilical

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 27 años, G2P1, 38 semanas, en trabajo de parto activo con 6 cm de dilatación. Membranas se rompen espontáneamente durante la exploración. Inmediatamente se observa bradicardia fetal sostenida de 70 lpm.

Al tacto vaginal se palpa estructura pulsátil por delante de la presentación cefálica. La paciente se encuentra hemodinámicamente estable.

El quirófano está disponible.

Pregunta

¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Iniciar oxitocina
B) Colocar a la paciente en posición genupectoral o Trendelenburg y elevar manualmente la presentación mientras se prepara cesárea *
C) Esperar recuperación espontánea
D) Aplicar fórceps

Retroalimentación

El prolapso de cordón es emergencia obstétrica. Se debe disminuir la compresión del cordón mientras se realiza cesárea urgente.

Tema: Trastornos hipertensivos

Subtema: Preeclampsia con datos de severidad

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 31 años, G1, 35 semanas. TA 165/110 mmHg, cefalea intensa persistente y fosfenos. Proteinuria ++. Plaquetas 110,000, AST 180 U/L.

FCF reactiva. Sin trabajo de parto.

Pregunta

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Manejo ambulatorio
B) Antihipertensivos y diferir resolución hasta 37 semanas
C) Hospitalización, sulfato de magnesio y resolución del embarazo tras estabilización *
D) Solo reposo

Retroalimentación

Preeclampsia con datos de severidad requiere estabilización con antihipertensivos, profilaxis anticonvulsiva y resolución independientemente de edad gestacional >34 semanas.

Tema: Hemorragia obstétrica

Subtema: Retención placentaria

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 22 años, G1P1, parto eutócico hace 40 minutos. Persistencia de placenta intrauterina sin signos claros de desprendimiento. Sangrado moderado continuo. Útero contraído parcialmente.

Signos vitales estables.

Pregunta

¿Cuál es la conducta indicada?

A) Esperar hasta 2 horas
B) Tracción vigorosa del cordón
C) Revisión manual de cavidad uterina bajo analgesia/anestesia adecuada *
D) Alta hospitalaria

Retroalimentación

Si la placenta no se expulsa en 30 minutos y hay sangrado, se indica extracción manual bajo condiciones controladas.

Tema: Infecciones en el embarazo

Subtema: Pielonefritis aguda

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 24 años, G1, 26 semanas. Refiere fiebre 39°C, dolor lumbar derecho y náusea. TA 100/60 mmHg, FC 115 lpm. Dolor a la puñopercusión lumbar derecha.

EGO con leucocituria y bacteriuria. Leucocitos 19,000.

Pregunta

¿Cuál es el manejo adecuado?

A) Antibiótico oral ambulatorio
B) Hospitalización y antibióticos IV *
C) Solo hidratación
D) Inducción del parto

Retroalimentación

La pielonefritis en embarazo requiere hospitalización por riesgo de sepsis y parto pretérmino.

Tema: Patología fetal

Subtema: Oligohidramnios severo a término

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 36 años, G2P1, 39 semanas. Refiere disminución de movimientos fetales. USG reporta índice de líquido amniótico de 3 cm. Perfil biofísico 6/10. Doppler normal.

Pregunta

¿Cuál es la conducta indicada?

A) Manejo expectante 2 semanas
B) Hidratación materna y reevaluar en 1 semana
C) Interrupción del embarazo *
D) Tocolíticos

Retroalimentación

Oligohidramnios severo a término es indicación de interrupción por riesgo de sufrimiento fetal.

Tema: Trastornos hipertensivos del embarazo

Subtema: Eclampsia intraparto

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 19 años, G1, 38 semanas, sin control prenatal adecuado. Ingresa en trabajo de parto con TA 170/115 mmHg, cefalea intensa y visión borrosa. Proteinuria +++. Durante la valoración presenta crisis convulsiva tónico-clónica generalizada de 90 segundos.

Posterior a la crisis: FCF 100 lpm con desaceleraciones tardías recurrentes. Dilatación 5 cm.

Pregunta 1

¿Cuál es el manejo inicial inmediato?

A) Diazepam IV
B) Sulfato de magnesio esquema de carga *
C) Fenitoína
D) Cesárea inmediata sin estabilización

Retroalimentación:
El tratamiento de primera línea para prevenir recurrencia convulsiva es sulfato de magnesio. Benzodiacepinas no son de elección inicial.

Pregunta 2

Tras estabilización materna, ¿cuál es la conducta obstétrica?

A) Manejo expectante hasta 40 semanas
B) Alta domiciliaria
C) Resolución del embarazo independientemente de la vía *
D) Suspender trabajo de parto

Retroalimentación:
La eclampsia es indicación de interrupción tras estabilización. La vía depende de condiciones obstétricas y estado fetal.

Tema: Hemorragias obstétricas

Subtema: Atonía uterina con choque hipovolémico

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 35 años, G4P4, parto vaginal hace 20 minutos. Producto de 4,300 g. Presenta sangrado masivo estimado en 1,800 mL. Útero flácido. TA 80/40 mmHg, FC 135 lpm, piel fría.

Se inicia masaje uterino y oxitocina sin respuesta inmediata.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Laceración cervical
B) Atonía uterina *
C) Inversión uterina
D) Retención placentaria

Retroalimentación:
Útero blando y sangrado abundante posparto sugieren atonía uterina como causa principal.

Pregunta 2

Además de uterotónicos, ¿cuál es parte fundamental del manejo inmediato?

A) Observación
B) Reposición agresiva de volumen y protocolo de transfusión masiva *
C) Alta hospitalaria
D) Solo ácido tranexámico

Retroalimentación:
Debe iniciarse reanimación hemodinámica inmediata con cristaloides y hemoderivados según protocolo.

Tema: Infecciones obstétricas

Subtema: Sepsis puerperal

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 28 años, 5 días postcesárea. Presenta fiebre 39°C, hipotensión 85/50 mmHg, taquicardia 125 lpm, loquios fétidos y dolor abdominal intenso. Lactato elevado.

Se sospecha foco uterino.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico sindromático?

A) Fiebre puerperal simple
B) Sepsis puerperal *
C) Mastitis
D) Endometritis leve

Retroalimentación:
Hipotensión + taquicardia + foco infeccioso indican sepsis.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta inicial?

A) Antibiótico oral
B) Antibióticos IV de amplio espectro y protocolo de sepsis *
C) Solo líquidos
D) Legrado inmediato sin antibióticos

Retroalimentación:
Se debe iniciar antibiótico IV de amplio espectro y manejo integral de sepsis (ABC, líquidos, monitoreo).

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Sufrimiento fetal agudo intraparto

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 30 años, G2P1, 40 semanas, en fase activa con 8 cm de dilatación. Monitor muestra desaceleraciones tardías repetitivas, variabilidad mínima y taquicardia fetal 170 lpm. Contracciones adecuadas.

No fiebre materna.

Pregunta 1

¿Qué patrón cardiotocográfico presenta?

A) Categoría I
B) Categoría II
C) Categoría III *
D) Reactivo normal

Retroalimentación:
Desaceleraciones tardías + variabilidad mínima indican patrón categoría III.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta?

A) Continuar trabajo de parto
B) Cesárea urgente si no hay mejoría inmediata tras medidas intrauterinas *
C) Alta
D) Solo oxígeno

Retroalimentación:
Si no mejora tras suspensión de oxitocina, cambio de posición y oxígeno, debe resolverse de manera urgente.

Tema: Endocrinología obstétrica

Subtema: Cetoacidosis diabética en embarazo

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 26 años, G1, 30 semanas, DM1. Refiere vómito, poliuria y malestar. TA 100/60 mmHg, FC 120 lpm. Glucosa 380 mg/dL, pH 7.18, bicarbonato bajo, cetonas positivas. FCF 165 lpm.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Estado hiperglucémico hiperosmolar
B) Cetoacidosis diabética *
C) Hipoglucemia
D) Trabajo de parto pretérmino

Retroalimentación:
Hiperglucemia + acidosis metabólica + cetonas confirman CAD.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo prioritario?

A) Interrupción inmediata del embarazo
B) Insulina IV e hidratación intensiva *
C) Solo antibióticos
D) Tocolíticos

Retroalimentación:
Primero se estabiliza metabólicamente a la madre. La resolución obstétrica depende de respuesta materno-fetal.

Tema: Hemorragias del primer trimestre

Subtema: Aborto diferido (retenido)

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 30 años, G2P1, 11 semanas por FUM. Acude por manchado escaso oscuro desde hace 3 días, sin dolor tipo cólico intenso. Refiere disminución de síntomas gestacionales (náusea y mastalgia).

Exploración: TA 110/70 mmHg. Cérvix cerrado. Útero acorde a 9 semanas.

USG transvaginal: saco gestacional con embrión de 8 semanas sin actividad cardiaca. No líquido libre.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Amenaza de aborto
B) Aborto incompleto
C) Aborto diferido *
D) Embarazo anembrionado

Retroalimentación:
Embrión sin actividad cardiaca con cérvix cerrado corresponde a aborto diferido (retenido).

Pregunta 2

¿Cuál es una opción de manejo adecuada en paciente hemodinámicamente estable?

A) Solo vigilancia obligatoria
B) Misoprostol para evacuación uterina *
C) Histerectomía
D) Antibióticos IV obligatorios

Retroalimentación:
En paciente estable puede optarse por manejo médico con misoprostol o manejo quirúrgico según preferencia y condiciones clínicas.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Fase activa prolongada

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 25 años, G1, 40 semanas, en trabajo de parto. Dilatación progresa de 6 a 7 cm en 5 horas, con dinámica uterina adecuada (4–5 contracciones/10 min). Pelvis clínica adecuada. Membranas rotas hace 6 horas. FCF normal.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Trabajo de parto normal
B) Fase latente prolongada
C) Prolongación de fase activa *
D) Arresto secundario

Retroalimentación:
En fase activa se espera progresión mayor; progreso lento con dinámica adecuada sugiere prolongación de fase activa.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta inicial?

A) Cesárea inmediata
B) Revalorar proporción cefalopélvica y considerar conducción con oxitocina *
C) Alta domiciliaria
D) Tocolíticos

Retroalimentación:
Debe evaluarse causa (potencia, pasajero, pelvis) y optimizar dinámica antes de decidir cesárea.

Tema: Hemorragias del tercer trimestre

Subtema: Desprendimiento prematuro de placenta leve

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 29 años, G2P1, 36 semanas. Dolor abdominal leve continuo y sangrado oscuro escaso. TA 130/85 mmHg. Útero discretamente doloroso. FCF 140 lpm reactiva.

USG sin placenta previa.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Placenta previa
B) Desprendimiento prematuro de placenta leve *
C) Ruptura uterina
D) Trabajo de parto normal

Retroalimentación:
Dolor + sangrado oscuro y útero sensible orientan a DPPNI.

Pregunta 2

Si madre y feto están estables, ¿cuál es la conducta?

A) Cesárea inmediata obligatoria
B) Manejo expectante con vigilancia estrecha *
C) Alta inmediata
D) Tocolíticos

Retroalimentación:
En casos leves sin compromiso puede optarse por vigilancia hospitalaria.

Tema: Infecciones del embarazo

Subtema: VIH en embarazo

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 27 años, G1, 32 semanas. Diagnóstico reciente de VIH. Carga viral 15,000 copias/mL. No tratamiento previo. Sin complicaciones obstétricas.

Pregunta 1

¿Cuál es la medida más importante para reducir transmisión vertical?

A) Cesárea obligatoria en todos los casos
B) Terapia antirretroviral combinada *
C) Antibióticos
D) Interrupción del embarazo

Retroalimentación:
El control de carga viral con TAR reduce significativamente transmisión vertical.

Pregunta 2

Si al final del embarazo la carga viral es >1,000 copias/mL, ¿qué se recomienda?

A) Parto vaginal
B) Cesárea electiva *
C) Inducción obligatoria
D) Nada adicional

Retroalimentación:
Carga viral elevada al final del embarazo es indicación de cesárea programada para reducir transmisión.

Tema: Complicaciones tromboembólicas

Subtema: Tromboembolia pulmonar en embarazo

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 34 años, G2P1, 30 semanas. Inicio súbito de disnea, dolor torácico pleurítico y taquicardia 120 lpm. Saturación 88%. Sin fiebre. Pierna derecha con edema leve.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Neumonía
B) Tromboembolia pulmonar *
C) Crisis asmática
D) Edema agudo pulmonar

Retroalimentación:
Disnea súbita, hipoxemia y factores de riesgo sugieren TEP.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Warfarina
B) Heparina de bajo peso molecular *
C) Aspirina
D) Trombólisis inmediata en todos los casos

Retroalimentación:
HBPM es tratamiento de elección en embarazo salvo inestabilidad grave.

Tema: Patología fetal

Subtema: Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) temprana con Doppler alterado

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 32 años, G1, 30 semanas. Antecedente de hipertensión crónica. Refiere disminución de movimientos fetales.

USG: peso fetal estimado en percentil 5, líquido amniótico en límite inferior normal. Doppler de arteria umbilical con índice de pulsatilidad elevado y flujo diastólico ausente intermitente. Doppler de arteria cerebral media con redistribución ("brain sparing"). Perfil biofísico 8/10.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Feto pequeño constitucional
B) RCIU tardía
C) RCIU temprana con insuficiencia placentaria *
D) Macrosomía fetal

Retroalimentación:
RCIU antes de 32 semanas con Doppler alterado y redistribución cerebral sugiere insuficiencia placentaria significativa.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Interrupción inmediata sin maduración pulmonar
B) Maduración pulmonar y vigilancia Doppler seriada *
C) Alta domiciliaria
D) Inducción inmediata del parto

Retroalimentación:
En ausencia de deterioro severo, se administra corticoesteroide y se vigila estrechamente con Doppler seriado.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Desproporción cefalopélvica

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 24 años, G1, 40 semanas. Trabajo de parto con dinámica adecuada durante 6 horas en fase activa. Dilatación permanece en 6 cm sin cambios. Cabeza fetal en -2 estación persistente. Pelvis clínica estrecha en conjugado diagonal. FCF normal.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fase activa normal
B) Arresto secundario de dilatación por desproporción cefalopélvica *
C) Hipodinamia uterina
D) Fase latente prolongada

Retroalimentación:
Falta de progresión con dinámica adecuada y estación alta sugiere desproporción.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta indicada?

A) Aumentar oxitocina indefinidamente
B) Cesárea *
C) Tocolíticos
D) Esperar 12 horas más

Retroalimentación:
En sospecha de desproporción cefalopélvica, la vía de resolución es cesárea.

Tema: Endocrinología obstétrica

Subtema: Hipotiroidismo subclínico en embarazo

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 29 años, G1, 10 semanas. Asintomática. Tamiz prenatal muestra TSH 6.5 mUI/L (elevada para primer trimestre), T4 libre normal. Anticuerpos anti-TPO positivos.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Hipertiroidismo
B) Hipotiroidismo clínico
C) Hipotiroidismo subclínico *
D) Función tiroidea normal

Retroalimentación:
TSH elevada con T4 normal corresponde a hipotiroidismo subclínico.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta adecuada?

A) No tratar
B) Iniciar levotiroxina *
C) Solo repetir estudio en tercer trimestre
D) Propiltiouracilo

Retroalimentación:
En embarazo, especialmente con anti-TPO positivos, debe iniciarse levotiroxina para reducir riesgo obstétrico.

Tema: Infecciones del embarazo

Subtema: Sífilis gestacional

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 23 años, G1, 24 semanas. VDRL 1:32, prueba treponémica confirmatoria positiva. Asintomática. Feto con biometría acorde a edad gestacional.

Pregunta 1

¿Cuál es el tratamiento indicado?

A) Azitromicina
B) Penicilina G benzatínica *
C) Ceftriaxona oral
D) No tratar si asintomática

Retroalimentación:
La penicilina es el único tratamiento eficaz para prevenir sífilis congénita.

Pregunta 2

Si la paciente fuera alérgica a penicilina, ¿qué se recomienda?

A) Doxiciclina
B) Eritromicina
C) Desensibilización y administrar penicilina *
D) No tratar

Retroalimentación:
En embarazo debe realizarse desensibilización, ya que no hay alternativa equivalente para prevención fetal.

Tema: Hemorragia obstétrica

Subtema: Laceración cervical posparto

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 26 años, G2P2, parto vaginal instrumentado con fórceps. Posterior al alumbramiento presenta sangrado abundante. Útero firme y contraído.

TA 95/60 mmHg. Al revisar canal del parto se identifica desgarro cervical sangrante.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más probable de la hemorragia?

A) Atonía uterina
B) Retención placentaria
C) Laceración cervical *
D) Inversión uterina

Retroalimentación:
Útero firme descarta atonía; debe sospecharse lesión del canal del parto.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo indicado?

A) Más oxitocina
B) Sutura quirúrgica del desgarro *
C) Masaje uterino
D) Esperar resolución espontánea

Retroalimentación:
Las lesiones del canal del parto requieren reparación quirúrgica inmediata.

Tema: Patología hepática del embarazo

Subtema: Colestasis intrahepática con criterios de interrupción

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 34 años, G2P1, 35 semanas. Refiere prurito intenso generalizado predominante en palmas y plantas, peor por la noche. Sin lesiones primarias.

Laboratorios: ácidos biliares 65 µmol/L (elevados), AST y ALT discretamente elevadas, bilirrubina normal. Perfil biofísico 8/10. Doppler normal.

Pregunta 1

¿Cuál es el principal riesgo fetal asociado?

A) Macrosomía
B) Restricción del crecimiento
C) Muerte fetal intrauterina súbita *
D) Cardiopatía congénita

Retroalimentación:
La elevación de ácidos biliares se asocia a muerte fetal súbita, especialmente >40 µmol/L.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta recomendada a esta edad gestacional con esos niveles?

A) Manejo expectante hasta 40 semanas
B) Interrupción del embarazo alrededor de las 36–37 semanas *
C) Solo antihistamínicos
D) Cesárea urgente inmediata sin indicación

Retroalimentación:
En colestasis con ácidos biliares elevados, se recomienda interrupción alrededor de 36–37 semanas para reducir riesgo de muerte fetal.

Tema: Emergencias obstétricas

Subtema: Embolia pulmonar masiva en puerperio

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 38 años, 3 días postcesárea. Obesidad grado II. Inicio súbito de disnea intensa, dolor torácico, síncope. TA 75/45 mmHg, FC 130 lpm, saturación 82%.

Se sospecha tromboembolia pulmonar masiva.

Pregunta 1

¿Cuál es el siguiente paso inmediato?

A) Radiografía simple
B) Iniciar anticoagulación empírica mientras se confirma diagnóstico si alta sospecha *
C) Esperar angiotomografía antes de actuar
D) Solo oxígeno

Retroalimentación:
En alta sospecha y compromiso hemodinámico, debe iniciarse anticoagulación inmediata.

Pregunta 2

Si persiste inestabilidad hemodinámica, ¿qué tratamiento puede considerarse?

A) Warfarina
B) Trombólisis sistémica *
C) Aspirina
D) Alta domiciliaria

Retroalimentación:
En TEP masiva con choque, está indicada trombólisis salvo contraindicación.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Líquido meconial espeso y manejo intraparto

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 29 años, G1, 41 semanas. Durante trabajo de parto se documenta salida de líquido amniótico espeso, verde oscuro. FCF 150 lpm con variabilidad moderada, sin desaceleraciones.

Pregunta 1

¿Qué significa la presencia de meconio espeso?

A) Infección materna
B) Madurez pulmonar
C) Posible hipoxia fetal previa *
D) Indicación automática de cesárea

Retroalimentación:
El meconio puede indicar estrés o hipoxia fetal previa, pero no implica cesárea automática.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta si el monitoreo es tranquilizador?

A) Cesárea obligatoria
B) Continuar vigilancia intraparto estrecha *
C) Suspender trabajo de parto
D) Tocolíticos

Retroalimentación:
Con FCF categoría I o II sin datos severos, se puede continuar con vigilancia.

Tema: Endocrinología obstétrica

Subtema: Diabetes pregestacional y malformaciones

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 25 años con DM1 desde la adolescencia. Embarazo no planeado. HbA1c al inicio 10%. USG estructural a las 20 semanas muestra defecto del tubo neural.

Pregunta 1

¿Cuál es el principal factor de riesgo para malformaciones en esta paciente?

A) Edad materna
B) Hiperglucemia en organogénesis *
C) Insulina
D) Hipotensión

Retroalimentación:
La hiperglucemia en el primer trimestre aumenta riesgo de malformaciones congénitas.

Pregunta 2

¿Qué medida preventiva reduce este riesgo en futuros embarazos?

A) Suspender insulina
B) Control glucémico estricto preconcepcional *
C) Cesárea programada
D) Solo ácido fólico sin control metabólico

Retroalimentación:
El control metabólico previo a la concepción reduce riesgo de anomalías congénitas.

Tema: Hemorragias obstétricas

Subtema: Coagulación intravascular diseminada secundaria a DPPNI

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 36 años, G3P2, 34 semanas, con DPPNI severo. Sangrado abundante, útero hipertónico. Laboratorios: plaquetas 60,000, fibrinógeno bajo, TP prolongado, sangrado por sitios de venopunción.

Pregunta 1

¿Cuál es la complicación presente?

A) Atonía uterina
B) Coagulación intravascular diseminada *
C) Sepsis
D) Trombocitosis

Retroalimentación:
Trombocitopenia + alteración de tiempos + sangrado difuso indican CID.

Pregunta 2

¿Cuál es parte fundamental del manejo?

A) Solo cristaloides
B) Reposición con hemoderivados según alteración (plasma, plaquetas, crioprecipitado) *
C) Aspirina
D) Alta

Retroalimentación:
La CID requiere reposición dirigida de factores y resolución de causa desencadenante.

Tema: Hemorragias del primer trimestre

Subtema: Embarazo molar completo

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 19 años, G1, 12 semanas por FUM. Refiere náusea y vómito severos, sangrado transvaginal oscuro intermitente y crecimiento uterino mayor al esperado.

Exploración: TA 150/95 mmHg. Útero correspondiente a 16 semanas. No se auscultan latidos fetales.

β-hCG marcadamente elevada (>200,000 mUI/mL).
USG: imagen en "tormenta de nieve", sin embrión visible.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Embarazo anembrionado
B) Embarazo molar completo *
C) Aborto diferido
D) Miomatosis uterina

Retroalimentación:
La imagen ecográfica en "tormenta de nieve", ausencia de embrión y β-hCG muy elevada sugieren mola completa.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo inicial indicado?

A) Histerectomía inmediata en toda paciente
B) Legrado uterino por aspiración *
C) Misoprostol
D) Manejo expectante

Retroalimentación:
El tratamiento inicial es evacuación uterina por aspiración. Histerectomía se reserva para casos seleccionados.

Pregunta 3

¿Cuál es el seguimiento obligatorio posterior?

A) Ultrasonido mensual únicamente
B) β-hCG seriada hasta negativización y seguimiento por 6–12 meses *
C) No requiere seguimiento
D) Anticoncepción opcional

Retroalimentación:
Debe vigilarse β-hCG seriada para detectar enfermedad trofoblástica persistente. Se recomienda anticoncepción durante seguimiento.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Presentación pélvica a término

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 28 años, G1, 39 semanas. USG confirma presentación pélvica franca. Peso fetal estimado 3,200 g. Pelvis clínica adecuada. Sin comorbilidades.

Pregunta 1

¿Cuál es la opción que puede ofrecerse antes del trabajo de parto?

A) Inducción inmediata
B) Versión cefálica externa *
C) Cesárea obligatoria inmediata
D) Tocolíticos indefinidos

Retroalimentación:
La versión cefálica externa puede intentarse alrededor de las 36–37 semanas si no hay contraindicaciones.

Pregunta 2

¿Cuál es la vía más frecuentemente recomendada en primigesta con presentación pélvica persistente?

A) Parto vaginal obligatorio
B) Cesárea programada *
C) Manejo expectante hasta 42 semanas
D) Fórceps

Retroalimentación:
En primigestas con presentación pélvica persistente suele recomendarse cesárea programada por menor riesgo neonatal.

Tema: Trastornos hipertensivos

Subtema: Hipertensión crónica con sobreagregación de preeclampsia

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 36 años con hipertensión crónica conocida desde antes del embarazo. Actualmente 32 semanas. TA habitual 140/90 mmHg. En consulta presenta TA 165/105 mmHg, proteinuria +++, plaquetas 130,000.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Hipertensión gestacional
B) Preeclampsia sobreagregada a hipertensión crónica *
C) Crisis hipertensiva aislada
D) HELLP

Retroalimentación:
Paciente con HTA previa que desarrolla proteinuria y datos de severidad cumple criterios de sobreagregación.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta?

A) Solo ajustar antihipertensivos
B) Hospitalización, sulfato de magnesio y valorar interrupción según estabilidad *
C) Alta domiciliaria
D) No requiere vigilancia

Retroalimentación:
Se maneja como preeclampsia con datos de severidad.

Tema: Infecciones perinatales

Subtema: Profilaxis para Streptococcus del grupo B (EGB)

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 25 años, G1, 39 semanas, en trabajo de parto. Cultivo rectovaginal a las 36 semanas positivo para Streptococcus grupo B. Sin alergias medicamentosas.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta intraparto?

A) No hacer nada
B) Penicilina G IV intraparto *

C) Cesárea obligatoria
D) Antibiótico oral

Retroalimentación:
La profilaxis intraparto reduce transmisión neonatal.

Pregunta 2

Si fuera alérgica a penicilina con reacción anafiláctica, ¿qué opción es adecuada?

A) Amoxicilina
B) Clindamicina si sensibilidad documentada *
C) Aspirina
D) No tratar

Retroalimentación:
En alergia grave se usa clindamicina si el germen es sensible.

Tema: Patología del puerperio

Subtema: Mastitis puerperal

Grado de dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 22 años, 3 semanas postparto. Refiere dolor en mama derecha, eritema localizado y fiebre 38.2°C. Lactancia activa. Sin fluctuación.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Absceso mamario
B) Mastitis puerperal *
C) Galactocele
D) Cáncer inflamatorio

Retroalimentación:
Dolor, eritema y fiebre en lactante sugieren mastitis.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta adecuada?

A) Suspender lactancia
B) Antibiótico y continuar lactancia *

C) Drenaje quirúrgico inmediato
D) No tratar

Retroalimentación:
Debe continuarse lactancia y administrar antibióticos dirigidos a S. aureus.

Tema: Patología trofoblástica gestacional

Subtema: Neoplasia trofoblástica gestacional postmolar

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 22 años con antecedente de embarazo molar completo evacuado hace 8 semanas. Seguimiento con β-hCG semanal mostró descenso inicial, pero en las últimas 3 determinaciones presenta meseta (5,200 → 5,400 → 5,350 mUI/mL). Asintomática. USG sin restos evidentes.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Embarazo nuevo
B) Restos placentarios
C) Neoplasia trofoblástica gestacional *
D) Error de laboratorio

Retroalimentación:
Meseta o elevación de β-hCG tras evacuación molar sugiere enfermedad trofoblástica persistente.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo inicial en enfermedad de bajo riesgo?

A) Histerectomía inmediata
B) Quimioterapia con metotrexato *
C) Nuevo legrado obligatorio
D) Observación sin tratamiento

Retroalimentación:
En enfermedad de bajo riesgo (según puntaje FIGO), el tratamiento es quimioterapia con agente único como metotrexato.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Distocia por hipodinamia uterina

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 26 años, G1, 39 semanas, en fase activa con 5 cm de dilatación. Tras 4 horas solo progresa a 6 cm. Dinámica uterina: 2 contracciones en 10 minutos, de intensidad leve. FCF normal.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más probable del retraso?

A) Desproporción cefalopélvica
B) Hipodinamia uterina *
C) Presentación anómala
D) Ruptura uterina

Retroalimentación:
Dinámica insuficiente con progreso lento sugiere alteración de la potencia uterina.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta adecuada?

A) Cesárea inmediata
B) Conducción con oxitocina bajo monitoreo *
C) Alta domiciliaria
D) Tocolíticos

Retroalimentación:
Debe optimizarse la dinámica uterina antes de decidir cesárea.

Tema: Hemorragias del segundo trimestre

Subtema: Placenta previa diagnosticada antes de 28 semanas

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 30 años, G2P1, 24 semanas. USG muestra placenta parcialmente cubriendo OCI. Asintomática.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Cesárea inmediata
B) Inducción del parto

C) Vigilancia y reevaluación ecográfica posterior *
D) Reposo absoluto hospitalario obligatorio

Retroalimentación:
Muchas placentas migran conforme avanza el embarazo; debe reevaluarse en tercer trimestre.

Pregunta 2

¿Qué está contraindicado en estas pacientes si presentan sangrado?

A) Ultrasonido transvaginal
B) Tacto vaginal digital *
C) Hospitalización
D) Monitoreo fetal

Retroalimentación:
El tacto vaginal puede desencadenar hemorragia masiva.

Tema: Endocrinología obstétrica

Subtema: Hipertiroidismo en el primer trimestre

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 27 años, G1, 9 semanas. Palpitaciones, pérdida de peso y temblor. TSH suprimida, T4 libre elevada. Anticuerpos TRAb positivos.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tirotoxicosis gestacional transitoria
B) Enfermedad de Graves *
C) Hipotiroidismo
D) Preeclampsia

Retroalimentación:
Anticuerpos TRAb positivos orientan a enfermedad de Graves.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de elección en el primer trimestre?

A) Metimazol
B) Propiltiouracilo *

C) Yodo radiactivo
D) No tratar

Retroalimentación:
En primer trimestre se prefiere propiltiouracilo por menor riesgo teratogénico comparado con metimazol.

Tema: Complicaciones del puerperio

Subtema: Absceso mamario

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 24 años, 4 semanas postparto. Dolor intenso en mama izquierda, fiebre 38.8°C. Área eritematosa con fluctuación palpable. No mejoró tras 72 horas de antibiótico por mastitis.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Mastitis simple
B) Galactocele
C) Absceso mamario *
D) Ingurgitación

Retroalimentación:
La presencia de fluctuación sugiere colección purulenta.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo adecuado?

A) Solo cambiar antibiótico
B) Drenaje del absceso + antibiótico *
C) Suspender lactancia definitiva
D) No tratar

Retroalimentación:
El absceso requiere drenaje además de antibiótico dirigido.

Tema: Patología hipertensiva del embarazo

Subtema: Preeclampsia antes de las 34 semanas sin datos de severidad

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 29 años, G1, 31 semanas. TA 150/95 mmHg en dos ocasiones separadas por 6 horas. Proteinuria 400 mg en 24 horas. Sin cefalea, sin fosfenos. Plaquetas 180,000, AST y ALT normales. FCF reactiva, Doppler normal.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Hipertensión gestacional
B) Preeclampsia sin datos de severidad *
C) Preeclampsia con datos de severidad
D) Hipertensión crónica

Retroalimentación:
HTA + proteinuria después de 20 semanas sin daño orgánico corresponde a preeclampsia sin datos de severidad.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Interrupción inmediata
B) Manejo expectante hospitalario con vigilancia materno-fetal *
C) Alta sin seguimiento
D) Solo antihipertensivos ambulatorios

Retroalimentación:
Antes de 34 semanas sin datos de severidad puede optarse por manejo expectante bajo vigilancia estrecha.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Parto pretérmino espontáneo

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 23 años, G2P1, 32 semanas. Contracciones regulares cada 5 minutos desde hace 2 horas. Dilatación 3 cm, borramiento 70%. Membranas íntegras. FCF reactiva.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Amenaza de parto pretérmino
B) Trabajo de parto pretérmino establecido *

C) Fase latente normal
D) RPM

Retroalimentación:
Cambios cervicales + dinámica regular antes de 37 semanas indican trabajo de parto pretérmino.

Pregunta 2

¿Cuál es parte fundamental del manejo?

A) Interrupción inmediata
B) Corticoesteroides para maduración pulmonar *
C) Cesárea obligatoria
D) Alta domiciliaria

Retroalimentación:
Entre 24–34 semanas deben administrarse corticoesteroides para maduración pulmonar fetal.

Pregunta 3

¿En qué caso están indicados tocolíticos?

A) Siempre
B) Si no hay infección ni compromiso fetal para permitir efecto de corticoesteroides *
C) Nunca
D) Solo después de 37 semanas

Retroalimentación:
Tocolíticos pueden utilizarse para ganar 48 horas para maduración pulmonar si no hay contraindicaciones.

Tema: Hemorragias obstétricas

Subtema: Acretismo placentario diagnosticado intraparto

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 39 años, G5P4, antecedente de 3 cesáreas. Durante cesárea programada se intenta desprender placenta y se observa invasión profunda sin plano de clivaje, con hemorragia activa masiva.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Placenta previa
B) Placenta acreta *
C) DPPNI
D) Atonía uterina

Retroalimentación:
Ausencia de plano de separación sugiere acretismo.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Insistir en desprendimiento manual
B) Histerectomía obstétrica *
C) Solo suturar
D) Cerrar y observar

Retroalimentación:
El manejo definitivo suele ser histerectomía para controlar hemorragia.

Tema: Infecciones perinatales

Subtema: Toxoplasmosis en embarazo

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 26 años, G1, 18 semanas. Serología: IgM positiva, IgG negativa. Refiere contacto frecuente con gatos. Asintomática.

Pregunta 1

¿Qué indica este resultado?

A) Infección pasada
B) Infección aguda probable *
C) Inmunidad protectora
D) Resultado irrelevante

Retroalimentación:
IgM positiva con IgG negativa sugiere infección reciente; debe confirmarse con pruebas adicionales.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento inicial si se confirma infección materna sin evidencia fetal?

A) Pirimetamina-sulfadiazina inmediata
B) Espiramicina *
C) No tratar
D) Interrupción obligatoria

Retroalimentación:
Espiramicina reduce transmisión vertical cuando no hay evidencia de infección fetal.

Tema: Puerperio

Subtema: Depresión posparto

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 30 años, 6 semanas postparto. Refiere tristeza persistente, insomnio, anhedonia y sentimientos de culpa. Niega ideación suicida. Funcionalidad disminuida.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tristeza posparto transitoria
B) Psicosis puerperal
C) Depresión posparto *
D) Trastorno bipolar

Retroalimentación:
Síntomas >2 semanas con afectación funcional sugieren depresión posparto.

Pregunta 2

¿Cuál es una opción terapéutica segura en lactancia?

A) Suspender lactancia obligatoriamente
B) ISRS como sertralina *
C) No tratar
D) Benzodiacepinas como monoterapia prolongada

Retroalimentación:
Algunos ISRS como sertralina son compatibles con lactancia.

Tema: Patología hipertensiva del embarazo

Subtema: Preeclampsia con datos de severidad y manejo intrahospitalario

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 32 años, G2P1, 35 semanas de gestación, acude por cefalea intensa holocraneana de 12 horas de evolución, fosfenos y dolor en epigastrio irradiado a hipocondrio derecho. Refiere edema progresivo en extremidades inferiores desde hace una semana. A la exploración: TA 170/110 mmHg en dos tomas separadas por 15 minutos, FC 96 lpm, FR 20 rpm. Reflejos osteotendinosos ++ con discreta hiperreflexia. No hay datos de trabajo de parto. FCF 150 lpm reactiva.

Laboratorios:
Plaquetas 95,000/mm^3
AST 110 U/L
ALT 95 U/L
Creatinina 1.3 mg/dL
Proteinuria 3+ en tira reactiva

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hipertensión gestacional
B) Preeclampsia sin datos de severidad
C) Preeclampsia con datos de severidad *
D) Síndrome HELLP completo

Retroalimentación:
HTA ≥160/110 + plaquetopenia + elevación de enzimas hepáticas + síntomas neurológicos = preeclampsia con datos de severidad. No cumple criterios completos de HELLP (falta evidencia clara de hemólisis).

Pregunta 2

¿Cuál es la primera intervención farmacológica prioritaria?

A) Inducción inmediata sin tratamiento previo
B) Administración de sulfato de magnesio *
C) Tocolíticos
D) Corticoesteroides para maduración pulmonar exclusivamente

Retroalimentación:
El sulfato de magnesio es fundamental para prevención de eclampsia en pacientes con datos de severidad.

Pregunta 3

¿Cuál es la conducta obstétrica definitiva?

A) Manejo expectante hasta 37 semanas
B) Interrupción del embarazo tras estabilización materna *

C) Alta domiciliaria
D) Solo antihipertensivos ambulatorios

Retroalimentación:
Después de 34 semanas con datos de severidad, la conducta es interrupción tras estabilizar a la paciente.

Tema: Hemorragias obstétricas

Subtema: Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI)

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 28 años, G3P2, 37 semanas, con antecedente de hipertensión gestacional en embarazo previo. Acude por dolor abdominal súbito, intenso y constante, acompañado de sangrado vaginal oscuro en moderada cantidad. Refiere disminución de movimientos fetales.

A la exploración: TA 150/95 mmHg, abdomen con hipertonía uterina y dolor difuso a la palpación. FCF 90 lpm con desaceleraciones tardías repetitivas.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Placenta previa
B) Ruptura uterina
C) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta *
D) Trabajo de parto normal

Retroalimentación:
Dolor intenso + útero hipertónico + sangrado oscuro + sufrimiento fetal son característicos de DPPNI.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Observación
B) Cesárea urgente *
C) Inducción con oxitocina
D) Alta

Retroalimentación:
Hay sufrimiento fetal agudo; la vía de resolución debe ser inmediata.

Pregunta 3

¿Cuál complicación materna es frecuente en casos graves?

A) Diabetes gestacional
B) Coagulación intravascular diseminada *
C) Hipertiroidismo
D) Sepsis urinaria

Retroalimentación:
El DPPNI severo puede desencadenar CID por liberación masiva de tromboplastina.

Tema: Endocrinología ginecológica

Subtema: Síndrome de ovario poliquístico (SOP) y criterios diagnósticos

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 24 años con ciclos menstruales irregulares desde la adolescencia. Presenta aumento progresivo de vello facial y acné. IMC 31 kg/m^2. Refiere dificultad para embarazarse tras 1 año de relaciones sin protección.

Laboratorios:
Testosterona total ligeramente elevada.
TSH normal.
Prolactina normal.
USG transvaginal: ovarios aumentados de volumen con múltiples folículos periféricos pequeños.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hiperprolactinemia
B) Síndrome de ovario poliquístico *
C) Insuficiencia ovárica prematura
D) Hipotiroidismo

Retroalimentación:
Cumple criterios de Rotterdam: oligo/anovulación + hiperandrogenismo clínico/biológico + ovarios poliquísticos.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento inicial si no desea embarazo?

A) Clomifeno
B) Anticonceptivos hormonales combinados *

C) Histerectomía
D) Solo metformina obligatoria

Retroalimentación:
Los ACO regulan ciclos y disminuyen hiperandrogenismo.

Pregunta 3

Si desea embarazo, ¿cuál es primera línea para inducir ovulación?

A) Letrozol *
B) Anticonceptivos
C) GnRH continuo
D) Danazol

Retroalimentación:
Letrozol es actualmente primera línea para inducción de ovulación en SOP.

Tema: Infecciones ginecológicas

Subtema: Enfermedad pélvica inflamatoria complicada

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 27 años con antecedente de múltiples parejas sexuales y uso irregular de preservativo. Consulta por dolor pélvico de 5 días de evolución, fiebre 38.5°C y flujo vaginal purulento. A la exploración: dolor intenso a movilización cervical y dolor anexial bilateral. USG muestra masa anexial compleja de 6 cm compatible con absceso tubo-ovárico.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Apendicitis
B) Embarazo ectópico
C) Enfermedad pélvica inflamatoria complicada con absceso tubo-ovárico *
D) Quiste simple

Retroalimentación:
Dolor pélvico + fiebre + masa anexial compleja sugiere absceso tubo-ovárico.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo inicial?

A) Tratamiento ambulatorio oral
B) Hospitalización y antibióticos IV de amplio espectro *
C) Solo analgésicos
D) Histerectomía inmediata

Retroalimentación:
Absceso tubo-ovárico requiere manejo intrahospitalario.

Pregunta 3

¿Cuándo está indicado drenaje quirúrgico?

A) Siempre de entrada
B) Si no hay respuesta a antibiótico o hay ruptura *
C) Nunca
D) Solo si mide menos de 3 cm

Retroalimentación:
La falta de mejoría clínica o complicación obliga a intervención.

Tema: Embarazo ectópico

Subtema: Manejo médico vs quirúrgico

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 30 años, G2P0A1, acude por dolor pélvico unilateral izquierdo de 48 horas de evolución, tipo punzante, intensidad progresiva. Refiere amenorrea de 7 semanas y manchado vaginal escaso oscuro desde hace 3 días. Niega síncope.

Exploración: TA 110/70 mmHg, FC 88 lpm. Abdomen con dolor en fosa iliaca izquierda sin datos de irritación peritoneal. A la exploración ginecológica: cérvix cerrado, dolor a movilización cervical, masa anexial izquierda dolorosa.

β-hCG: 2,300 mUI/mL
USG transvaginal: no se observa saco intrauterino, masa anexial izquierda de 2.5 cm, sin líquido libre significativo.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Amenaza de aborto
B) Embarazo ectópico tubárico no complicado *
C) Quiste hemorrágico
D) Aborto incompleto

Retroalimentación:
Amenorrea + β-hCG mayor al umbral discriminatorio sin saco intrauterino + masa anexial = embarazo ectópico.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo más adecuado en este caso?

A) Laparotomía urgente
B) Metotrexato sistémico *
C) Legrado uterino
D) Observación sin tratamiento

Retroalimentación:
Paciente estable, masa <3.5 cm, sin latido embrionario y β-hCG baja → candidata a tratamiento médico.

Pregunta 3

¿Cuál es un criterio absoluto para tratamiento quirúrgico inmediato?

A) Deseo reproductivo futuro
B) Hemodinámicamente inestable *
C) Edad menor de 35 años
D) β-hCG menor de 5,000

Retroalimentación:
Inestabilidad hemodinámica implica ruptura y requiere intervención urgente.

Tema: Hemorragia obstétrica

Subtema: Atonía uterina en el puerperio inmediato

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 34 años, G4P4, parto vaginal eutócico hace 20 minutos. Producto de 3,900 g. Placenta completa. Presenta sangrado abundante transvaginal que empapa compresas rápidamente. TA 95/60 mmHg, FC 115 lpm.

A la palpación abdominal: útero aumentado de tamaño, blando y mal contraído.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más probable de la hemorragia?

A) Retención placentaria
B) Atonía uterina *
C) Laceración cervical
D) Inversión uterina

Retroalimentación:
Útero blando y aumentado de tamaño tras parto sugiere atonía, principal causa de hemorragia posparto.

Pregunta 2

¿Cuál es la primera intervención?

A) Histerectomía inmediata
B) Masaje uterino bimanual + oxitocina IV *
C) Alta domiciliaria
D) Antibióticos

Retroalimentación:
El manejo inicial incluye masaje uterino y uterotónicos.

Pregunta 3

Si no responde a oxitocina, ¿cuál es el siguiente fármaco útil?

A) Misoprostol o metilergonovina (según contraindicación) *
B) Tocolíticos
C) Corticoesteroides
D) Insulina

Retroalimentación:
Se deben escalar uterotónicos antes de medidas quirúrgicas.

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Cáncer cervicouterino etapa temprana

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 41 años, sin tamizaje en los últimos 10 años. Consulta por sangrado poscoital intermitente. Especuloscopía: lesión exofítica friable de 2 cm en cérvix. Biopsia: carcinoma epidermoide invasor.

RM pélvica: tumor limitado al cuello uterino, 2.2 cm, sin invasión parametrial.

Pregunta 1

Según FIGO, ¿en qué etapa se encuentra?

A) IA
B) IB1 *
C) IIB
D) IIIA

Retroalimentación:
Tumor visible clínicamente ≤4 cm limitado al cérvix corresponde a IB1.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de elección en paciente candidata quirúrgica?

A) Quimioterapia exclusiva
B) Histerectomía radical + linfadenectomía *
C) Observación
D) Crioterapia

Retroalimentación:
En etapas tempranas operables, la cirugía radical es tratamiento estándar.

Pregunta 3

Principal factor etiológico asociado:

A) Virus Epstein-Barr
B) Virus del papiloma humano de alto riesgo *
C) VIH
D) Herpes simple

Retroalimentación:
VPH 16 y 18 son los principales subtipos oncogénicos.

Tema: Obstetricia

Subtema: Ruptura prematura de membranas pretérmino (RPM pretérmino)

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 25 años, G1, 30 semanas. Refiere salida súbita de líquido claro abundante hace 6 horas. No contracciones. TA normal. Temperatura 37.8°C. FCF reactiva.

Especuloscopía: líquido claro en fondo de saco. Prueba de nitrazina positiva.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Incontinencia urinaria
B) RPM pretérmino *
C) Trabajo de parto activo
D) Placenta previa

Retroalimentación:
Salida de líquido antes de 37 semanas sin trabajo de parto = RPM pretérmino.

Pregunta 2

¿Cuál es parte fundamental del manejo antes de 34 semanas si no hay infección?

A) Inducción inmediata
B) Manejo expectante + antibióticos + corticoesteroides *
C) Alta domiciliaria
D) Cesárea obligatoria

Retroalimentación:
Se busca prolongar embarazo y reducir complicaciones neonatales.

Pregunta 3

¿Qué dato obligaría a terminar el embarazo inmediatamente?

A) FCF reactiva
B) Corioamnionitis clínica *
C) Edad materna joven
D) Producto femenino

Retroalimentación:
Fiebre, taquicardia materno-fetal y dolor uterino sugieren infección intraamniótica → interrupción.

Tema: Diabetes en el embarazo

Subtema: Cetoacidosis diabética en embarazo

Grado de dificultad: Muy Alta

Caso clínico:

Paciente de 27 años, G2P1, 28 semanas de gestación, antecedente de diabetes tipo 1 desde los 14 años. Acude por 24 horas de náuseas intensas, vómito y dolor abdominal difuso. Refiere haber suspendido parcialmente su insulina por inapetencia.

Exploración: TA 100/60 mmHg, FC 120 lpm, FR 28 rpm con respiración profunda. Mucosas secas. FCF 170 lpm.

Laboratorios:
Glucosa 280 mg/dL

pH 7.18
Bicarbonato 12 mEq/L
Cetonas positivas en sangre
Anión gap elevado

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Gastroenteritis
B) Hiperglucemia simple
C) Cetoacidosis diabética *
D) Preeclampsia

Retroalimentación:
En embarazo la CAD puede presentarse con glucemias no tan elevadas. Acidosis metabólica con anión gap elevado y cetonemia confirman diagnóstico.

Pregunta 2

¿Cuál es la prioridad inicial del manejo?

A) Cesárea inmediata
B) Rehidratación con solución cristaloide IV *
C) Sulfato de magnesio
D) Tocolíticos

Retroalimentación:
La reposición de volumen es el primer paso antes de insulina IV.

Pregunta 3

¿La presencia de taquicardia fetal obliga a interrupción inmediata?

A) Sí siempre
B) No, primero se corrige estado metabólico materno *
C) Solo si es femenino
D) Siempre antes de 30 semanas

Retroalimentación:
La mayoría de alteraciones fetales mejoran al corregir la acidosis materna.

Tema: Hemorragias del primer trimestre

Subtema: Aborto séptico

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 22 años, 10 semanas por FUM, acude por fiebre de 39°C, dolor abdominal bajo intenso y sangrado vaginal fétido. Refiere intento de interrupción del embarazo con instrumento no médico hace 3 días.

Exploración: TA 90/55 mmHg, FC 118 lpm. Abdomen doloroso con datos de irritación peritoneal leve. Cérvix abierto con restos ovulares visibles.

Laboratorios: leucocitosis marcada con neutrofilia.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Aborto incompleto
B) Aborto inevitable
C) Aborto séptico *
D) Embarazo ectópico

Retroalimentación:
Fiebre alta + restos retenidos + manipulación uterina previa orientan a aborto séptico.

Pregunta 2

¿Cuál es el manejo inicial?

A) Legrado inmediato sin antibióticos
B) Antibióticos IV de amplio espectro + estabilización hemodinámica *
C) Alta con tratamiento oral
D) Observación

Retroalimentación:
Primero estabilización y antibióticos; evacuación uterina posterior cuando esté hemodinámicamente estable.

Pregunta 3

Complicación más temida:

A) Hipotiroidismo
B) Choque séptico *
C) Diabetes
D) Insuficiencia ovárica

Retroalimentación:
La progresión a sepsis y choque es frecuente si no se trata oportunamente.

Tema: Climaterio

Subtema: Terapia hormonal de reemplazo (THR)

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 52 años, menopausia desde hace 1 año. Presenta bochornos intensos, sudoración nocturna y trastorno del sueño que afecta su calidad de vida. IMC 24. No antecedentes de cáncer de mama ni enfermedad tromboembólica. Útero íntegro.

Pregunta 1

¿Es candidata a terapia hormonal?

A) No, está contraindicada siempre
B) Sí, si no hay contraindicaciones mayores *
C) Solo si tiene osteoporosis
D) Solo si tiene hipertensión

Retroalimentación:
En mujeres sintomáticas menores de 60 años o <10 años de menopausia sin contraindicaciones, puede indicarse THR.

Pregunta 2

¿Qué esquema es adecuado si conserva útero?

A) Estrógeno solo
B) Estrógeno + progestágeno *
C) Progesterona sola obligatoria
D) Andrógenos

Retroalimentación:
Se requiere progestágeno para proteger endometrio del riesgo de hiperplasia/cáncer.

Pregunta 3

Principal riesgo a largo plazo asociado:

A) Cáncer de mama (según tipo y duración) *
B) Cáncer gástrico
C) Cáncer renal
D) Hipertiroidismo

Retroalimentación:
El riesgo aumenta con uso prolongado de combinaciones hormonales.

Tema: Obstetricia

Subtema: Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU)

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 33 años, G1, 34 semanas. Antecedente de hipertensión crónica. Refiere disminución de movimientos fetales. Altura uterina menor a la esperada para edad gestacional.

USG: peso fetal estimado < percentil 5, líquido amniótico disminuido. Doppler de arteria umbilical con aumento de resistencia.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Feto grande para edad gestacional
B) Restricción del crecimiento intrauterino *
C) Embarazo gemelar
D) Placenta previa

Retroalimentación:
Peso estimado <P10 con alteración Doppler confirma RCIU.

Pregunta 2

Principal etiología en este caso:

A) Diabetes materna
B) Hipertensión materna crónica *
C) Infección urinaria
D) Hipertiroidismo

Retroalimentación:
La insuficiencia placentaria secundaria a HTA es causa frecuente.

Pregunta 3

¿Qué hallazgo Doppler es de mayor gravedad?

A) Flujo normal
B) Ausencia o reversa de flujo diastólico en arteria umbilical *
C) Índice de pulsatilidad bajo
D) Doppler normal

Retroalimentación:
La ausencia o reversión del flujo diastólico se asocia a alto riesgo de muerte fetal.

Tema: Patología hipertensiva del embarazo

Subtema: Síndrome HELLP

Grado de dificultad: Muy Alta

Caso clínico:

Paciente de 34 años, G3P2, 33 semanas de gestación. Acude por dolor intenso en epigastrio irradiado a hipocondrio derecho desde hace 8 horas, náusea y malestar general. Refiere cefalea leve. Sin antecedentes patológicos relevantes.

Exploración: TA 155/100 mmHg, FC 102 lpm. Edema en extremidades inferiores ++. Reflejos osteotendinosos aumentados. Útero acorde a edad gestacional. FCF 150 lpm reactiva.

Laboratorios:
Plaquetas 68,000/mm^3
AST 210 U/L
ALT 190 U/L
Bilirrubina indirecta elevada
LDH elevada
Esquistocitos en frotis

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Preeclampsia sin severidad
B) Hepatitis aguda viral
C) Síndrome HELLP *
D) Colestasis intrahepática

Retroalimentación:
Hemólisis (LDH y bilirrubina elevada + esquistocitos), enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia = HELLP.

Pregunta 2

¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Manejo expectante hasta 37 semanas
B) Sulfato de magnesio + estabilización e interrupción del embarazo *
C) Solo antihipertensivos
D) Alta domiciliaria

Retroalimentación:
HELLP es indicación de interrupción independientemente de edad gestacional tras estabilizar.

Pregunta 3

Complicación materna grave asociada:

A) Rotura hepática *
B) Hipotiroidismo
C) Diabetes
D) Placenta previa

Retroalimentación:
Puede progresar a hematoma subcapsular y ruptura hepática.

Tema: Hemorragias del tercer trimestre

Subtema: Placenta previa total sintomática

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 37 años, G4P3, 36 semanas, antecedente de dos cesáreas previas. Consulta por sangrado vaginal rojo brillante abundante, indoloro, de inicio súbito. Niega dolor abdominal.

Exploración: TA 105/70 mmHg, FC 100 lpm. Útero relajado, no doloroso. FCF 140 lpm reactiva. USG muestra placenta cubriendo completamente el orificio cervical interno.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) DPPNI
B) Placenta previa total *
C) Ruptura uterina
D) Trabajo de parto

Retroalimentación:
Sangrado rojo brillante, indoloro, con útero relajado es característico.

Pregunta 2

Conducta obstétrica:

A) Inducción con oxitocina
B) Cesárea programada o urgente según estabilidad *
C) Tacto vaginal para valorar dilatación
D) Alta

Retroalimentación:
Placenta cubriendo OCI contraindica parto vaginal.

Pregunta 3

Principal factor de riesgo en esta paciente:

A) Primigesta
B) Cesáreas previas *
C) Edad <20 años
D) Hipertiroidismo

Retroalimentación:
Cicatrices uterinas aumentan riesgo de placenta previa.

Tema: Endocrinología ginecológica

Subtema: Hiperprolactinemia y galactorrea

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 28 años consulta por amenorrea de 6 meses y salida espontánea de secreción láctea bilateral. Niega embarazo. No usa anticonceptivos. Refiere cefalea leve ocasional.

Laboratorios:
β-hCG negativa
TSH normal
Prolactina 120 ng/mL

Pregunta 1

¿Cuál es el siguiente estudio?

A) USG pélvico
B) Resonancia magnética de hipófisis *
C) TAC abdominal
D) Biopsia mamaria

Retroalimentación:
Prolactina >100 ng/mL sugiere prolactinoma; se debe estudiar hipófisis.

Pregunta 2

Tratamiento de primera línea:

A) Cirugía inmediata
B) Agonista dopaminérgico (cabergolina o bromocriptina) *
C) Radioterapia
D) Estrógenos

Retroalimentación:
Agonistas dopaminérgicos reducen prolactina y tamaño tumoral.

Pregunta 3

Complicación si el macroadenoma progresa:

A) Hemorragia uterina
B) Hemianopsia bitemporal *
C) Diabetes
D) Osteoporosis inmediata

Retroalimentación:
Compresión del quiasma óptico produce defecto campimétrico típico.

Tema: Obstetricia

Subtema: Isoinmunización Rh

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 26 años, G2P1, 28 semanas. Grupo O Rh negativo. Primer embarazo terminó en parto vaginal sin aplicación documentada de inmunoglobulina anti-D. En control actual se detecta Coombs indirecto positivo con títulos elevados.

USG muestra signos iniciales de hidropesía fetal leve.

Pregunta 1

¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico?

A) Infección viral
B) Producción materna de anticuerpos anti-D que atraviesan placenta *
C) Diabetes
D) Insuficiencia tiroidea

Retroalimentación:
La sensibilización previa genera anticuerpos IgG que destruyen eritrocitos fetales.

Pregunta 2

¿Qué estudio evalúa anemia fetal de forma no invasiva?

A) Amniocentesis sistemática
B) Doppler de arteria cerebral media *

C) Tacto vaginal
D) Perfil hepático

Retroalimentación:
Aumento de velocidad sistólica en ACM se correlaciona con anemia fetal.

Pregunta 3

Tratamiento si anemia fetal severa:

A) Alta
B) Transfusión intrauterina *
C) Solo hierro oral
D) Reposo

Retroalimentación:
La transfusión intrauterina puede salvar al feto antes de la viabilidad para parto.

Tema: Hemorragias del primer trimestre

Subtema: Aborto retenido

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 29 años, G1, 9 semanas por FUM. Refiere desaparición de náuseas y mastalgia desde hace una semana. Niega sangrado abundante. Solo manchado marrón escaso. Sin dolor significativo.

Exploración: cérvix cerrado, útero menor al esperado.
USG transvaginal: saco gestacional con embrión de 8 semanas sin actividad cardiaca.

Pregunta

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Aborto incompleto
B) Amenaza de aborto
C) Aborto retenido *
D) Embarazo anembrionado

Retroalimentación:
Embrión sin actividad cardiaca con cérvix cerrado y sin expulsión corresponde a aborto retenido.

Tema: Embarazo ectópico

Subtema: Ectópico roto

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 26 años, amenorrea de 6 semanas. Dolor abdominal súbito intenso, síncope en domicilio. TA 85/50 mmHg, FC 130 lpm. Abdomen con rebote positivo. USG FAST: líquido libre abundante en cavidad.

β-hCG 4,500 mUI/mL.

Pregunta

Conducta inmediata:

A) Metotrexato
B) Observación
C) Laparotomía urgente *
D) Legrado

Retroalimentación:
Inestabilidad hemodinámica = ruptura tubárica → cirugía inmediata.

Tema: Patología hipertensiva

Subtema: Eclampsia

Grado de dificultad: Muy Alta

Caso clínico:

Paciente de 19 años, 36 semanas, presenta convulsión tónico-clónica generalizada en sala de espera. TA 180/115 mmHg. Posterior al evento se encuentra somnolienta.

Pregunta

Tratamiento inmediato:

A) Diazepam como único manejo
B) Sulfato de magnesio *
C) Fenitoína
D) Cesárea inmediata sin estabilizar

Retroalimentación:
Sulfato de magnesio es el tratamiento de elección para prevenir recurrencias.

Tema: Hemorragia obstétrica

Subtema: Laceración cervical

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente con parto vaginal instrumentado. Presenta sangrado abundante, pero útero firme y bien contraído.

Pregunta

Causa más probable:

A) Atonía uterina
B) Retención placentaria
C) Laceración cervical *
D) CID

Retroalimentación:
Útero contraído con sangrado activo sugiere lesión del canal del parto.

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: NIC II–III

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente de 32 años con citología que reporta HSIL. Colposcopía con lesión acetoblanca extensa. Biopsia: NIC III.

Pregunta

Conducta:

A) Observación
B) Antibióticos
C) Escisión con asa (LEEP) *
D) Histerectomía radical

Retroalimentación:
Lesiones de alto grado requieren tratamiento escisional.

Tema: Endocrinología reproductiva

Subtema: Amenorrea secundaria – insuficiencia ovárica prematura

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 35 años con amenorrea de 8 meses, bochornos y sequedad vaginal. FSH elevada en dos determinaciones separadas.

Pregunta

Diagnóstico:

A) SOP
B) Embarazo
C) Insuficiencia ovárica prematura *
D) Hiperprolactinemia

Retroalimentación:
FSH elevada persistentemente antes de los 40 años indica falla ovárica.

Tema: Obstetricia

Subtema: Macrosomía fetal

Grado de dificultad: Media–Alta

Caso clínico:

Paciente con diabetes gestacional mal controlada. USG estima peso fetal 4,400 g a las 39 semanas.

Pregunta

Principal riesgo intraparto:

A) Prolapso de cordón
B) Distocia de hombros *
C) Placenta previa
D) Corioamnionitis

Retroalimentación:
Macrosomía se asocia a distocia de hombros.

Tema: Infecciones en embarazo

Subtema: Corioamnionitis

Grado de dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente 32 semanas con RPM hace 48 horas. Presenta fiebre 38.5°C, taquicardia materna y fetal, dolor uterino.

Pregunta

Conducta:

A) Continuar manejo expectante
B) Antibióticos IV + interrupción del embarazo *
C) Tocolíticos
D) Alta

Retroalimentación:
Corioamnionitis es indicación de terminación del embarazo.

Tema: Hemorragias del segundo trimestre

Subtema: Vasa previa

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 31 años, G2P1, 35 semanas, acude por ruptura espontánea de membranas en domicilio seguida de sangrado vaginal rojo brillante moderado. Refiere disminución brusca de movimientos fetales. No presenta dolor abdominal.

Exploración: TA 110/70 mmHg, FC 92 lpm. Útero no doloroso. FCF 80 lpm persistente. USG previo reportaba inserción velamentosa del cordón.

Pregunta

Diagnóstico más probable:

A) Placenta previa
B) DPPNI
C) Vasa previa *
D) Ruptura uterina

Retroalimentación:
Sangrado posterior a RPM con bradicardia fetal y madre estable sugiere ruptura de vasos fetales.

Tema: Patología hipertensiva

Subtema: Hipertensión gestacional

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 24 años, G1, 37 semanas. TA 145/92 mmHg en dos mediciones separadas por 4 horas. Sin proteinuria. Laboratorios normales. Asintomática.

Pregunta

Diagnóstico:

A) Preeclampsia
B) Hipertensión crónica
C) Hipertensión gestacional *
D) Síndrome HELLP

Retroalimentación:
HTA después de 20 semanas sin proteinuria ni daño orgánico.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Desproporción cefalopélvica

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente primigesta, 40 semanas, en trabajo de parto activo con 6 cm de dilatación desde hace 5 horas pese a adecuada dinámica uterina (4 contracciones en 10 min, intensidad adecuada). Cabeza en estación -2 persistente. Feto estimado 4,100 g.

Pregunta

Causa más probable del arresto:

A) Hipodinamia
B) Desproporción cefalopélvica *
C) Presentación pélvica
D) Ruptura uterina

Retroalimentación:
Buena dinámica + falta de descenso sugiere problema mecánico.

Tema: Endocrinología obstétrica

Subtema: Diabetes gestacional diagnóstico

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 29 años, 26 semanas. Curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 g:
Ayuno 98 mg/dL
1 hora 190 mg/dL
2 horas 160 mg/dL

Pregunta

Interpretación:

A) Normal
B) Intolerancia leve
C) Diabetes gestacional *
D) Diabetes tipo 2

Retroalimentación:
Uno o más valores alterados según criterios diagnósticos confirman diabetes gestacional.

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Cáncer de ovario epitelial

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 58 años, distensión abdominal progresiva, pérdida de peso y sensación de saciedad temprana. USG muestra masa anexial compleja bilateral con ascitis. CA-125 elevado.

Pregunta

Diagnóstico más probable:

A) Quiste funcional
B) Endometrioma
C) Cáncer epitelial de ovario *
D) Embarazo ectópico

Retroalimentación:
Masa compleja bilateral + ascitis + CA-125 elevado en posmenopáusica es altamente sugestivo.

Tema: Puerperio

Subtema: Trombosis venosa profunda

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 30 años, 10 días postcesárea. Dolor y aumento de volumen en pierna izquierda. Signo de Homans positivo. Doppler venoso confirma trombosis femoral.

Pregunta

Tratamiento:

A) Warfarina inmediata
B) Heparina de bajo peso molecular *
C) Aspirina
D) No tratar

Retroalimentación:
HBPM es tratamiento inicial seguro en puerperio.

Tema: Infecciones ginecológicas

Subtema: Vaginosis bacteriana

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 25 años con flujo vaginal grisáceo, olor a “pescado” que aumenta tras coito. pH vaginal 5.5. Prueba de aminas positiva.

Pregunta

Agente más asociado:

A) Candida albicans
B) Gardnerella vaginalis *
C) Trichomonas vaginalis
D) Neisseria gonorrhoeae

Retroalimentación:
Clínica clásica de vaginosis bacteriana.

Tema: Obstetricia

Subtema: Polihidramnios

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 34 semanas con aumento excesivo de altura uterina. USG reporta índice de líquido amniótico de 28 cm. Feto con sospecha de atresia esofágica.

Pregunta

Mecanismo fisiopatológico:

A) Disminución producción renal fetal
B) Aumento de deglución fetal
C) Disminución deglución fetal *
D) Hipertensión materna

Retroalimentación:
Malformaciones gastrointestinales impiden deglución adecuada de líquido amniótico.

Tema: Hemorragias del tercer trimestre

Subtema: Ruptura uterina

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 38 años, G5P4, con antecedente de dos cesáreas previas. Cursa 39 semanas y se encuentra en trabajo de parto con prueba de trabajo después de cesárea. Presenta súbitamente dolor abdominal intenso, diferente al de las contracciones, seguido de cese de la dinámica uterina. Refiere sensación de “desgarro”. Se observa sangrado vaginal moderado.

Exploración: TA 90/60 mmHg, FC 120 lpm. Abdomen doloroso, partes fetales fácilmente palpables. FCF 70 lpm sostenida.

Pregunta

¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Oxitocina para reiniciar dinámica
B) Cesárea urgente con probable reparación o histerectomía *
C) Observación
D) Analgesia y vigilancia

Retroalimentación:
Ante antecedente de cesárea + dolor súbito + bradicardia fetal + inestabilidad materna, el diagnóstico es ruptura uterina y requiere intervención quirúrgica inmediata.

Tema: Patología hipertensiva

Subtema: Preeclampsia con datos neurológicos

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 25 años, 34 semanas, acude por cefalea intensa, fosfenos y visión borrosa de 24 horas de evolución. TA 165/105 mmHg. Proteinuria 2+. Plaquetas 140,000. Creatinina normal.

Reflejos osteotendinosos aumentados. No convulsiones.

Pregunta

¿Cuál es el siguiente paso en el manejo?

A) Alta con antihipertensivos orales
B) Sulfato de magnesio y preparación para interrupción *
C) Tocolíticos
D) Solo reposo

Retroalimentación:
Síntomas neurológicos son datos de severidad aunque las plaquetas sean normales. Requiere profilaxis anticonvulsiva y resolución.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Distocia de hombros

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente con diabetes gestacional. Parto vaginal en curso a las 39 semanas. Tras salida de la cabeza fetal se observa retracción contra el periné ("signo de la tortuga"). No progresa el resto del cuerpo.

Pregunta

Primera maniobra indicada:

A) Tracción fuerte de la cabeza
B) Maniobra de McRoberts *
C) Cesárea inmediata
D) Fórceps

Retroalimentación:
La maniobra de McRoberts es el primer paso para liberar hombro anterior impactado.

Tema: Endocrinología ginecológica

Subtema: Síndrome de Asherman

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 33 años con antecedente de legrado uterino posterior a aborto complicado hace un año. Desde entonces presenta hipomenorrea progresiva hasta amenorrea. Desea embarazo. Prueba de progesterona negativa (no sangrado).

Pregunta

Estudio diagnóstico de elección:

A) USG simple
B) Histeroscopía diagnóstica *
C) Resonancia cerebral
D) TAC abdominal

Retroalimentación:
Ante sospecha de sinequias intrauterinas, la histeroscopía es el estándar diagnóstico y terapéutico.

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Cáncer de endometrio

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 62 años, obesa, diabética, con menopausia desde hace 12 años. Consulta por sangrado transvaginal escaso intermitente de 2 meses de evolución. USG transvaginal reporta endometrio de 14 mm.

Pregunta

Siguiente paso:

A) Observación
B) Biopsia endometrial *
C) Antibióticos
D) Terapia hormonal inmediata

Retroalimentación:
Sangrado postmenopáusico + endometrio engrosado obliga a descartar carcinoma con biopsia.

Tema: Obstetricia

Subtema: Oligohidramnios

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 36 semanas con antecedente de hipertensión crónica. Refiere disminución de movimientos fetales. USG muestra índice de líquido amniótico de 4 cm. Doppler con aumento de resistencia en arteria umbilical.

Pregunta

Principal mecanismo en este contexto:

A) Aumento de producción fetal
B) Insuficiencia placentaria *
C) Malformación renal bilateral
D) Diabetes materna

Retroalimentación:
En hipertensión crónica, la disminución del flujo uteroplacentario reduce perfusión renal fetal y producción de orina.

Tema: Hemorragias del primer trimestre

Subtema: Embarazo anembrionado

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 27 años, G1, 8 semanas por FUM, acude para ultrasonido de control. Refiere náuseas leves y mastalgia. Niega dolor o sangrado abundante, solo manchado escaso marrón en días previos.

Exploración: cérvix cerrado, útero acorde a 8 semanas.
USG transvaginal: saco gestacional de 30 mm sin embrión visible ni saco vitelino.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Aborto incompleto
B) Embarazo anembrionado *
C) Embarazo ectópico
D) Amenaza de aborto

Retroalimentación:
Saco ≥25 mm sin embrión visible confirma embarazo anembrionado.

Pregunta 2

Opciones de manejo incluyen:

A) Solo observación obligatoria
B) Manejo expectante, médico o quirúrgico según caso *
C) Antibióticos
D) Tocolíticos

Retroalimentación:
Puede manejarse de forma expectante, con misoprostol o legrado según preferencia y condiciones clínicas.

Tema: Patología hipertensiva

Subtema: Hipertensión crónica con sobreagregación de preeclampsia

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 36 años con antecedente de hipertensión arterial crónica desde hace 5 años. Cursa 32 semanas. Habitualmente TA 135/85 mmHg con tratamiento. Consulta por edema súbito, cefalea y elevación de TA a 160/100 mmHg. Proteinuria 1.2 g en 24 horas.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Hipertensión gestacional
B) Preeclampsia sobreagregada a hipertensión crónica *
C) Crisis hipertensiva aislada
D) Eclampsia

Retroalimentación:
Nueva proteinuria y empeoramiento tensional en paciente previamente hipertensa sugieren sobreagregación.

Pregunta 2

Principal riesgo fetal asociado:

A) Macrosomía
B) Restricción del crecimiento intrauterino *
C) Polihidramnios
D) Hidropesía

Retroalimentación:
La insuficiencia placentaria es más frecuente en este contexto.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Presentación pélvica

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente primigesta, 38 semanas, producto único en presentación pélvica franca diagnosticada por USG. Peso estimado 3,200 g. Pelvis clínicamente adecuada. Sin comorbilidades.

Pregunta 1

Conducta recomendada en la mayoría de los casos:

A) Inducción del parto vaginal sistemática
B) Cesárea electiva *
C) Tocolíticos
D) Observación hasta 42 semanas

Retroalimentación:
La presentación pélvica en primigesta generalmente se maneja por cesárea programada.

Pregunta 2

Complicación fetal más temida en parto vaginal pélvico:

A) Prolapso de cordón *
B) Macrosomía
C) Placenta previa
D) Oligohidramnios

Retroalimentación:
El prolapso de cordón es más frecuente en presentaciones no cefálicas.

Tema: Endocrinología reproductiva

Subtema: Hiperplasia endometrial

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 48 años con sangrado uterino anormal crónico. IMC 34 kg/m^2. USG: endometrio 16 mm. Biopsia: hiperplasia endometrial sin atipia.

Pregunta 1

Principal mecanismo fisiopatológico:

A) Exceso de progesterona
B) Exposición prolongada a estrógenos sin oposición *
C) Infección viral
D) Deficiencia androgénica

Retroalimentación:
La obesidad favorece aromatización periférica y exceso estrogénico.

Pregunta 2

Tratamiento inicial:

A) Histerectomía inmediata
B) Progestágenos *
C) Quimioterapia
D) Antibióticos

Retroalimentación:
En ausencia de atipia, se manejan con terapia progestacional.

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Tumor germinal de ovario (Disgerminoma)

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 19 años con dolor abdominal progresivo y masa anexial sólida unilateral de 10 cm. Marcadores: LDH elevada, AFP normal.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Cistadenoma seroso
B) Disgerminoma *
C) Endometrioma
D) Quiste funcional

Retroalimentación:
Tumor sólido en mujer joven con LDH elevada orienta a disgerminoma.

Pregunta 2

Tratamiento inicial en paciente joven con deseo reproductivo:

A) Ooforectomía unilateral con estadificación *
B) Histerectomía total
C) Solo quimioterapia
D) Observación

Retroalimentación:
Se preserva fertilidad si es unilateral y en etapa temprana.

Tema: Obstetricia

Subtema: Prolapso de cordón umbilical

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 35 semanas en trabajo de parto, presentación transversa. Tras ruptura artificial de membranas se observa cordón umbilical protruyendo por vagina. FCF 90 lpm.

Pregunta 1

Diagnóstico:

A) Placenta previa
B) Prolapso de cordón *
C) DPPNI
D) Vasa previa

Retroalimentación:
Visualización del cordón tras ruptura de membranas confirma diagnóstico.

Pregunta 2

Conducta inmediata:

A) Intentar reintroducir cordón y continuar trabajo
B) Elevar presentación fetal manualmente y cesárea urgente *
C) Oxitocina
D) Observación

Retroalimentación:
Debe aliviarse compresión mientras se prepara resolución quirúrgica urgente.

Tema: Patología hipertensiva del embarazo

Subtema: Eclampsia intraparto

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 21 años, primigesta, 38 semanas, sin control prenatal adecuado. Ingresa en trabajo de parto activo con 6 cm de dilatación. TA al ingreso 155/100 mmHg. Refiere cefalea leve desde la mañana.

Durante su estancia presenta crisis convulsiva tónico-clónica generalizada de aproximadamente 1 minuto. Posteriormente queda somnolienta, con respiración espontánea conservada. FCF 140 lpm reactiva. No hay datos de desprendimiento placentario.

Laboratorios posteriores: plaquetas 130,000; AST ligeramente elevada; creatinina normal.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Epilepsia
B) Crisis hipertensiva aislada
C) Eclampsia *
D) Síndrome HELLP

Retroalimentación:
Convulsión en paciente embarazada con datos hipertensivos sin otra causa aparente es eclampsia hasta demostrar lo contrario.

Pregunta 2

¿Cuál es la primera medida terapéutica específica?

A) Diazepam como manejo único
B) Sulfato de magnesio en dosis de impregnación y mantenimiento *
C) Fenitoína
D) Inducción inmediata sin estabilizar

Retroalimentación:
El sulfato de magnesio es el fármaco de elección para prevenir recurrencia convulsiva.

Pregunta 3

Tras estabilización materna, la conducta obstétrica es:

A) Manejo expectante hasta 40 semanas
B) Interrupción del embarazo independientemente de edad gestacional *
C) Alta domiciliaria
D) Solo antihipertensivos

Retroalimentación:
La eclampsia es indicación de terminación del embarazo una vez estabilizada la madre.

Tema: Hemorragia obstétrica

Subtema: Inversión uterina

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 29 años, parto vaginal eutócico hace 15 minutos. Tras tracción excesiva del cordón durante el alumbramiento presenta dolor súbito intenso y hemorragia profusa. Se observa masa rojiza protruyendo por vagina. TA 85/55 mmHg, FC 125 lpm.

A la palpación abdominal no se identifica fondo uterino en su posición habitual.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Atonía uterina
B) Laceración vaginal
C) Inversión uterina *
D) Retención placentaria

Retroalimentación:
Ausencia del fondo uterino abdominal y masa vaginal son característicos.

Pregunta 2

Primer paso en el manejo:

A) Histerectomía inmediata
B) Reposición manual urgente del útero + manejo del choque *
C) Antibióticos
D) Alta

Retroalimentación:
Debe intentarse reposición manual inmediata antes de que se instaure edema severo.

Tema: Endocrinología obstétrica

Subtema: Hipotiroidismo en embarazo

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 30 años, 10 semanas de gestación, antecedente de tiroiditis autoinmune. Consulta por fatiga marcada y aumento leve de peso. TSH 6.5 mUI/L, T4 libre baja.

No presenta bocio significativo.

Pregunta 1

Diagnóstico:

A) Hipertiroidismo
B) Hipotiroidismo clínico *
C) Tirotoxicosis gestacional
D) Función tiroidea normal

Retroalimentación:
TSH elevada con T4 baja confirma hipotiroidismo clínico.

Pregunta 2

Tratamiento indicado:

A) Suspender todo manejo
B) Levotiroxina ajustada a peso *
C) Metimazol
D) Yodo radiactivo

Retroalimentación:
El hipotiroidismo no tratado aumenta riesgo de aborto y alteraciones neurocognitivas fetales.

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Cáncer cervicouterino localmente avanzado

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 48 años con sangrado poscoital y flujo fétido desde hace 6 meses. Nunca se ha realizado Papanicolaou. Especuloscopía muestra lesión infiltrante que compromete cuello uterino y parametrios. RM confirma extensión parametrial sin invasión a pared pélvica.

Pregunta 1

Estadio probable:

A) IB
B) IIA
C) IIB *
D) IV

Retroalimentación:
Compromiso parametrial sin llegar a pared pélvica corresponde a estadio IIB.

Pregunta 2

Tratamiento de elección:

A) Histerectomía simple
B) Radioterapia externa + quimioterapia concomitante *
C) Observación
D) Crioterapia

Retroalimentación:
En enfermedad localmente avanzada no resecable, el estándar es radioquimioterapia.

Tema: Obstetricia

Subtema: Restricción del crecimiento intrauterino severa con Doppler crítico

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 32 años, 32 semanas, antecedente de preeclampsia leve. USG muestra peso fetal < percentil 3, oligohidramnios y Doppler con ausencia de flujo diastólico en arteria umbilical. Perfil biofísico 6/10.

Pregunta 1

Significado del Doppler:

A) Hallazgo normal
B) Insuficiencia placentaria severa *
C) Error técnico
D) Polihidramnios

Retroalimentación:
La ausencia de flujo diastólico indica alto riesgo de hipoxia fetal.

Pregunta 2

Conducta más adecuada:

A) Alta domiciliaria
B) Vigilancia estrecha y considerar interrupción según edad gestacional y condición fetal *
C) Solo vitaminas
D) Inducción inmediata sin valorar viabilidad

Retroalimentación:
La decisión depende del balance entre prematuridad y riesgo de muerte fetal.

Tema: Ginecología

Subtema: Miomatosis uterina sintomática

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 40 años con sangrado uterino abundante y dolor pélvico crónico. USG muestra múltiples miomas intramurales y submucosos, el mayor de 6 cm deformando cavidad endometrial. Desea preservar fertilidad.

Pregunta 1

Principal causa del sangrado:

A) Deficiencia estrogénica
B) Alteración estructural de la cavidad uterina *
C) Infección
D) Hiperprolactinemia

Retroalimentación:
Los miomas submucosos distorsionan endometrio y favorecen sangrado abundante.

Pregunta 2

Opción terapéutica conservadora:

A) Histerectomía total
B) Miomectomía *
C) Radioterapia
D) Quimioterapia

Retroalimentación:
En pacientes con deseo reproductivo, la miomectomía es alternativa conservadora.

Tema: Hemorragias del primer trimestre

Subtema: Aborto incompleto

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 32 años, G3P1A1, con amenorrea de 11 semanas, acude por sangrado vaginal abundante desde hace 8 horas acompañado de cólico hipogástrico intenso tipo contracción. Refiere expulsión parcial de tejido en domicilio.

Exploración: TA 105/65 mmHg, FC 98 lpm. Abdomen con dolor leve a la palpación profunda. Especuloscopía: sangrado activo moderado. Tacto vaginal: cérvix dilatado 2 cm, restos tisulares palpables en canal cervical.

USG transvaginal: cavidad uterina con material ecogénico heterogéneo compatible con restos ovulares retenidos.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Aborto retenido
B) Aborto incompleto *
C) Amenaza de aborto
D) Embarazo ectópico

Retroalimentación:
Sangrado abundante + cérvix dilatado + restos intrauterinos = aborto incompleto.

Pregunta 2

Conducta más adecuada en este momento:

A) Observación domiciliaria
B) Evacuación uterina (AMEU o legrado) *
C) Tocolíticos
D) Solo analgésicos

Retroalimentación:
El sangrado activo y restos retenidos indican evacuación uterina para prevenir hemorragia o infección.

Tema: Patología hipertensiva del embarazo

Subtema: Preeclampsia sin proteinuria (criterios actuales)

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 29 años, 35 semanas, con TA 160/105 mmHg en dos ocasiones separadas por 30 minutos. Niega proteinuria en tira reactiva. Refiere cefalea persistente y dolor en hipocondrio derecho. Laboratorios: plaquetas 110,000, AST 95 U/L, creatinina 1.4 mg/dL.

Pregunta 1

¿Puede diagnosticarse preeclampsia aunque no haya proteinuria?

A) No, es requisito obligatorio
B) Sí, si hay datos de daño orgánico *
C) Solo si hay edema
D) Solo con convulsiones

Retroalimentación:
Actualmente, el diagnóstico puede hacerse con HTA + datos de severidad aunque no exista proteinuria.

Pregunta 2

Clasificación en este caso:

A) Hipertensión gestacional
B) Preeclampsia sin severidad
C) Preeclampsia con datos de severidad *
D) HELLP

Retroalimentación:
Plaquetopenia, alteración hepática y elevación de creatinina son criterios de severidad.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Arresto de dilatación en fase activa

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Primigesta de 39 semanas en trabajo de parto. Dilatación 7 cm durante 6 horas pese a adecuada dinámica uterina documentada con monitorización interna (4–5 contracciones en 10 minutos, intensidad adecuada). Cabeza fetal en estación 0. Pelvis clínicamente adecuada. FCF normal.

Pregunta 1

Diagnóstico obstétrico:

A) Trabajo de parto normal
B) Arresto de dilatación en fase activa *
C) Desproporción cefalopélvica obligatoria
D) Hipodinamia

Retroalimentación:
Falta de progresión ≥4 horas con dinámica adecuada define arresto en fase activa.

Pregunta 2

Conducta:

A) Continuar indefinidamente
B) Cesárea *
C) Tocolíticos
D) Alta

Retroalimentación:
Arresto documentado con dinámica adecuada indica resolución quirúrgica.

Tema: Endocrinología ginecológica

Subtema: Síndrome de ovario poliquístico – complicaciones metabólicas

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 26 años con diagnóstico previo de SOP. IMC 33 kg/m^2. Acantosis nigricans en cuello. Ciclos irregulares persistentes. Glucosa en ayuno 112 mg/dL.

Pregunta 1

Principal alteración metabólica asociada:

A) Hipertiroidismo
B) Resistencia a la insulina *
C) Hipocalcemia
D) Deficiencia de cortisol

Retroalimentación:
El SOP se asocia frecuentemente a resistencia a la insulina y síndrome metabólico.

Pregunta 2

Intervención no farmacológica fundamental:

A) Reposo absoluto
B) Pérdida de peso mediante dieta y ejercicio *
C) Antibióticos
D) Terapia hormonal obligatoria

Retroalimentación:
La reducción de peso mejora ovulación y perfil metabólico.

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Cáncer de endometrio – factores de riesgo

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 59 años, nulípara, obesa, con antecedente de terapia estrogénica sin oposición por 5 años. Presenta sangrado postmenopáusico. Biopsia confirma adenocarcinoma endometrioide.

Pregunta 1

Principal factor fisiopatológico implicado:

A) Déficit estrogénico
B) Estimulación estrogénica sin oposición progestacional *
C) Infección viral
D) Trauma uterino

Retroalimentación:
El exceso estrogénico crónico favorece hiperplasia y progresión a carcinoma.

Pregunta 2

Tratamiento estándar en etapa temprana:

A) Radioterapia exclusiva
B) Histerectomía total con salpingooforectomía bilateral *
C) Observación
D) Anticonceptivos

Retroalimentación:
La cirugía es el tratamiento de elección en enfermedad localizada.

Tema: Obstetricia

Subtema: Embolia de líquido amniótico

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 35 años durante trabajo de parto presenta súbitamente disnea intensa, cianosis, hipotensión severa y pérdida de la conciencia. Posteriormente desarrolla sangrado incoercible por sitios de punción.

Se documenta hipoxemia severa y alteraciones compatibles con coagulación intravascular diseminada.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Trombosis venosa profunda
B) Embolia pulmonar clásica
C) Embolia de líquido amniótico *
D) Crisis asmática

Retroalimentación:
Colapso cardiovascular súbito intraparto + CID es altamente sugestivo.

Pregunta 2

Manejo inicial:

A) Anticoagulación inmediata
B) Soporte vital avanzado y manejo en UCI *
C) Alta
D) Solo antibióticos

Retroalimentación:
Es una emergencia obstétrica con manejo principalmente de soporte intensivo.

Tema: Hemorragias del tercer trimestre

Subtema: Placenta previa

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 34 años, G4P2A1, 35 semanas de gestación, antecedente de 2 cesáreas previas, acude por sangrado vaginal rojo brillante de inicio súbito, indoloro, en cantidad moderada. Niega actividad uterina dolorosa. Refiere movimientos fetales presentes.

Exploración: TA 110/70 mmHg, FC 92 lpm. Abdomen sin hipertonía uterina, no dolor a la palpación. FCF 140 lpm reactiva. No se realiza tacto vaginal digital. USG obstétrico: placenta cubriendo completamente el orificio cervical interno.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Desprendimiento prematuro de placenta
B) Placenta previa oclusiva total *
C) Vasa previa
D) Ruptura uterina

Retroalimentación:
Sangrado rojo brillante, indoloro y placenta cubriendo OCI es característico de placenta previa.

Pregunta 2

Conducta obstétrica más adecuada si el sangrado persiste:

A) Inducción con oxitocina
B) Cesárea programada urgente *
C) Tacto vaginal para valorar dilatación
D) Manejo ambulatorio

Retroalimentación:
Placenta previa oclusiva total es indicación absoluta de cesárea.

Tema: Hemorragias del tercer trimestre

Subtema: Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI)

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 29 años, 37 semanas, con antecedente de hipertensión gestacional, consulta por dolor abdominal intenso súbito acompañado de sangrado oscuro escaso. Refiere disminución de movimientos fetales.

Exploración: TA 150/95 mmHg, útero hipertónico, doloroso a la palpación, FCF 100 lpm con desaceleraciones tardías.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Placenta previa
B) DPPNI *
C) Trabajo de parto normal
D) Apendicitis

Retroalimentación:
Dolor + hipertonía uterina + sangrado oscuro sugieren desprendimiento placentario.

Pregunta 2

Conducta inmediata:

A) Observación 24 horas
B) Cesárea urgente *
C) Reposo domiciliario
D) Solo antihipertensivos

Retroalimentación:
Compromiso fetal + sospecha de DPPNI requiere resolución inmediata.

Tema: Infecciones en el embarazo

Subtema: Corioamnionitis

Dificultad: Media

Caso clínico:

Primigesta de 22 años, 38 semanas, con ruptura de membranas desde hace 20 horas. Presenta fiebre de 38.6°C, taquicardia materna y fetal (170 lpm). Líquido amniótico fétido.

Pregunta 1

Diagnóstico:

A) Sepsis urinaria
B) Corioamnionitis *
C) Endometritis postparto
D) Infección vaginal simple

Retroalimentación:
Fiebre + RPM prolongada + taquicardia fetal es diagnóstico clínico de corioamnionitis.

Pregunta 2

Manejo:

A) Solo antipiréticos
B) Antibióticos IV de amplio espectro y resolución del embarazo *
C) Esperar cultivo
D) Alta

Retroalimentación:
El tratamiento incluye antibióticos IV y culminación del embarazo.

Tema: Anticoncepción

Subtema: DIU en nulíparas

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 19 años, nuligesta, solicita anticoncepción de larga duración. Niega antecedentes de EPI. Ciclos regulares. Exploración normal.

Pregunta 1

¿Es el DIU una opción válida?

A) No, está contraindicado en nulíparas
B) Sí, es método seguro y eficaz *
C) Solo después del primer parto
D) Solo si es mayor de 25 años

Retroalimentación:
Las guías actuales permiten DIU en nulíparas sin contraindicación.

Pregunta 2

Principal mecanismo del DIU de cobre:

A) Inhibición ovulatoria
B) Reacción inflamatoria local espermicida *
C) Bloqueo cervical hormonal
D) Supresión hipofisaria

Retroalimentación:
El cobre genera reacción inflamatoria tóxica para espermatozoides.

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Cáncer cervicouterino – tamizaje

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 31 años, sin antecedentes patológicos, inicia vida sexual a los 17 años. Nunca se ha realizado citología cervical.

Pregunta 1

Método de tamizaje recomendado a su edad:

A) Colposcopía inicial
B) Papanicolaou cada 3 años *
C) Biopsia cervical
D) Solo prueba de embarazo

Retroalimentación:
En mujeres de 25–34 años se recomienda citología cervical periódica.

Pregunta 2

Principal factor etiológico del cáncer cervicouterino:

A) VPH oncogénico *
B) Cándida
C) Herpes simple
D) Trauma cervical

Retroalimentación:
VPH 16 y 18 son los principales responsables.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Distocia de hombros

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 28 años, G2P1, embarazo de 40 semanas con producto estimado de 4,200 g. Durante expulsivo, tras salida de la cabeza fetal, se observa retracción del mentón contra el periné ("signo de la tortuga"). No progresa el parto.

Pregunta 1

Diagnóstico:

A) Prolapso de cordón
B) Distocia de hombros *
C) Ruptura uterina
D) Presentación anómala

Retroalimentación:
El signo de la tortuga es clásico de distocia de hombros.

Pregunta 2

Primera maniobra indicada:

A) Maniobra de Kristeller
B) Maniobra de McRoberts *
C) Cesárea inmediata
D) Tracción forzada de cabeza

Retroalimentación:
McRoberts es la primera intervención recomendada.

Tema: Control prenatal

Subtema: Suplementación en embarazo

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Paciente de 24 años, primigesta, acude a su primera consulta prenatal con 9 semanas de gestación confirmadas por ultrasonido. No antecedentes patológicos. IMC 23 kg/m^2. No consumo de medicamentos previo. Refiere náuseas leves.

Pregunta específicamente qué suplementos debe iniciar para disminuir riesgos en su embarazo.

Exploración física normal. Laboratorios iniciales sin alteraciones.

Pregunta 1

¿Qué suplemento debe indicarse de rutina en el primer trimestre para prevenir defectos del tubo neural?

A) Hierro
B) Calcio
C) Ácido fólico *
D) Vitamina D

Retroalimentación:
El ácido fólico preconcepcional y durante el primer trimestre reduce el riesgo de defectos del tubo neural.

Pregunta 2

Dosis habitual recomendada en paciente sin factores de alto riesgo:

A) 0.4 mg al día *
B) 5 mg al día
C) 10 mg al día
D) 50 mg al día

Retroalimentación:
La dosis estándar es 0.4 mg diarios en embarazos de bajo riesgo.

Tema: Lactancia

Subtema: Beneficios de la lactancia materna exclusiva

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Puérpera de 26 años, 24 horas postparto eutócico, pregunta si puede complementar con fórmula porque “siente que no produce suficiente leche”. El recién nacido pesa 3,200 g, succión adecuada, signos vitales normales.

Pregunta 1

Recomendación actual sobre alimentación del recién nacido sano:

A) Fórmula desde el nacimiento
B) Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses *
C) Agua con glucosa adicional
D) Leche evaporada

Retroalimentación:
La recomendación es lactancia exclusiva los primeros 6 meses.

Pregunta 2

Principal beneficio inmunológico de la leche materna:

A) Contiene antibióticos sintéticos
B) Aporta IgA secretora *
C) Genera inmunidad artificial
D) Disminuye vacunación

Retroalimentación:
La IgA secretora protege contra infecciones gastrointestinales y respiratorias.

Tema: Infecciones ginecológicas

Subtema: Candidiasis vaginal

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Paciente de 28 años, sexualmente activa, consulta por prurito vulvar intenso, leucorrea blanca grumosa, sin olor fétido. pH vaginal 4.5. No dolor pélvico.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Vaginosis bacteriana
B) Candidiasis vulvovaginal *
C) Tricomoniasis
D) EPI

Retroalimentación:
Flujo blanco grumoso + prurito intenso y pH normal sugieren candidiasis.

Pregunta 2

Tratamiento de primera línea:

A) Metronidazol
B) Fluconazol dosis única *
C) Ceftriaxona
D) Doxiciclina

Retroalimentación:
Azoles son el tratamiento estándar en candidiasis no complicada.

Tema: Anticoncepción

Subtema: Anticoncepción hormonal combinada

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Mujer de 23 años sin antecedentes médicos, no fumadora, solicita método anticonceptivo reversible. No factores de riesgo trombótico.

Pregunta 1

Mecanismo principal de los anticonceptivos combinados:

A) Alteración endometrial exclusiva
B) Inhibición de la ovulación *
C) Destrucción espermática directa
D) Bloqueo tubárico

Retroalimentación:
Su principal mecanismo es inhibir el pico de LH y evitar la ovulación.

Pregunta 2

Principal contraindicación absoluta:

A) Edad menor de 30
B) Migraña con aura *
C) Nuliparidad
D) Dismenorrea

Retroalimentación:
Migraña con aura aumenta riesgo trombótico y es contraindicación.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Fases del trabajo de parto

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Primigesta de 39 semanas con contracciones regulares cada 4 minutos. Dilatación cervical 5 cm, borramiento 80%, membranas íntegras.

Pregunta 1

¿En qué fase del trabajo de parto se encuentra?

A) Fase latente
B) Fase activa *
C) Periodo expulsivo
D) Alumbramiento

Retroalimentación:
Dilatación ≥4–6 cm con contracciones regulares corresponde a fase activa.

Pregunta 2

Meta de progresión esperada en primigesta en fase activa:

A) 0.2 cm/h
B) 1 cm/h aproximadamente *
C) 5 cm/h
D) No hay referencia

Retroalimentación:
Se espera progresión aproximada de 1 cm por hora en primigestas.

Tema: Climaterio

Subtema: Diagnóstico de menopausia

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Paciente de 50 años refiere 13 meses sin menstruación. Presenta bochornos y sudoración nocturna. No usa anticonceptivos.

Pregunta 1

Criterio diagnóstico de menopausia:

A) 3 meses sin menstruación
B) 6 meses sin menstruación
C) 12 meses consecutivos sin menstruación *
D) FSH obligatoria

Retroalimentación:
La menopausia es diagnóstico clínico tras 12 meses de amenorrea.

Pregunta 2

Hormona que se encuentra elevada fisiológicamente:

A) Estradiol
B) FSH *
C) Progesterona
D) Prolactina

Retroalimentación:
La falla ovárica provoca elevación de FSH.

Tema: Patología hipertensiva del embarazo

Subtema: Eclampsia

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 21 años, primigesta, 33 semanas de gestación, sin control prenatal adecuado, es llevada a urgencias tras presentar episodio convulsivo tónico-clónico generalizado de aproximadamente 1 minuto de duración, con recuperación parcial del estado de alerta. Familiares refieren cefalea intensa progresiva desde hace 48 horas, fosfenos y edema facial.

Exploración: TA 170/115 mmHg, FC 105 lpm, FR 22 rpm. Edema en extremidades inferiores ++. Reflejos osteotendinosos exaltados. Altura uterina acorde a edad gestacional. FCF 150 lpm.

Laboratorios: plaquetas 135,000; AST 70 U/L; creatinina 1.2 mg/dL. Tira reactiva con proteinuria ++.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Epilepsia primaria
B) Preeclampsia sin severidad
C) Eclampsia *
D) Crisis hipertensiva aislada

Retroalimentación:
La presencia de convulsión en paciente con datos de preeclampsia confirma eclampsia, independientemente del nivel de proteinuria.

Pregunta 2

Tratamiento anticonvulsivante de primera línea:

A) Diazepam
B) Fenitoína
C) Sulfato de magnesio *
D) Ácido valproico

Retroalimentación:
El sulfato de magnesio es el fármaco de elección para prevenir recurrencia convulsiva en eclampsia.

Pregunta 3

Conducta obstétrica definitiva:

A) Prolongar embarazo hasta término
B) Interrumpir embarazo una vez estabilizada *
C) Solo antihipertensivos
D) Alta domiciliaria

Retroalimentación:
La resolución del embarazo es el tratamiento definitivo tras estabilización materna.

Tema: Hemorragia obstétrica

Subtema: Atonía uterina

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 30 años, G3P3, inmediatamente posterior a parto eutócico de producto de 4,100 g. Placenta íntegra expulsada. A los pocos minutos presenta sangrado vaginal abundante que empapa compresas rápidamente. Se observa útero aumentado de tamaño, blando, por arriba del ombligo.

TA 90/60 mmHg, FC 120 lpm. Paciente pálida, diaforética.

Pregunta 1

Causa más probable de la hemorragia:

A) Retención placentaria
B) Atonía uterina *
C) Laceración cervical
D) Coagulopatía primaria

Retroalimentación:
Útero blando y aumentado de tamaño en contexto inmediato postparto sugiere atonía uterina, causa más frecuente de hemorragia obstétrica.

Pregunta 2

Primera intervención:

A) Histerectomía inmediata
B) Masaje uterino bimanual *
C) Esperar evolución
D) Antibióticos

Retroalimentación:
El masaje uterino es la primera medida para estimular contracción.

Pregunta 3

Uterotónico de primera línea:

A) Metilergonovina
B) Oxitocina *
C) Misoprostol como primera opción obligatoria
D) Ácido tranexámico exclusivo

Retroalimentación:
La oxitocina IV es el uterotónico inicial recomendado.

Tema: Embarazo ectópico

Subtema: Manejo médico con metotrexato

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 27 años, G2P0A1, 7 semanas por FUM, acude por dolor pélvico leve y manchado escaso. Hemodinámicamente estable. BHCG 1,800 mUI/mL. USG transvaginal: no saco intrauterino visible, masa anexial derecha de 2.5 cm sin actividad cardiaca embrionaria, sin líquido libre significativo.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Aborto completo
B) Embarazo ectópico no complicado *
C) Quiste ovárico simple
D) Amenaza de aborto

Retroalimentación:
BHCG positiva sin saco intrauterino y masa anexial compatible sugiere ectópico.

Pregunta 2

Criterio que permite manejo médico:

A) Inestabilidad hemodinámica
B) Masa menor de 4 cm y sin latido embrionario *
C) Hemoperitoneo abundante
D) Dolor intenso con choque

Retroalimentación:
El manejo con metotrexato está indicado en pacientes estables con criterios específicos.

Tema: Infecciones de transmisión sexual

Subtema: Enfermedad pélvica inflamatoria

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 23 años consulta por dolor pélvico bilateral de 4 días de evolución, fiebre 38.3°C y leucorrea mucopurulenta. Refiere múltiples parejas sexuales y uso irregular de preservativo.

Exploración: dolor a la movilización cervical, dolor anexial bilateral. BH con leucocitosis leve.

Pregunta 1

Diagnóstico clínico más probable:

A) Apendicitis
B) Embarazo ectópico roto
C) Enfermedad pélvica inflamatoria *
D) Endometriosis

Retroalimentación:
Dolor a la movilización cervical + fiebre + flujo mucopurulento es criterio clínico de EPI.

Pregunta 2

Esquema antibiótico ambulatorio recomendado:

A) Ceftriaxona + doxiciclina + metronidazol *
B) Penicilina sola
C) Fluconazol
D) Azitromicina sola

Retroalimentación:
Se requiere cobertura para gonococo, clamidia y anaerobios.

Tema: Diabetes gestacional

Subtema: Tamizaje y diagnóstico

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 31 años, 26 semanas, IMC 31 kg/m^2, antecedente familiar de diabetes. Se realiza prueba de tamiz con 50 g de glucosa, resultado 165 mg/dL a la hora.

Pregunta 1

Conducta siguiente:

A) Diagnosticar diabetes gestacional
B) Realizar curva de tolerancia con 100 g *
C) Repetir tamiz
D) Iniciar insulina

Retroalimentación:
Tamiz alterado requiere prueba confirmatoria con carga de 100 g.

Pregunta 2

Complicación fetal asociada más frecuente:

A) Restricción del crecimiento
B) Macrosomía fetal *
C) Microcefalia
D) Atresia intestinal

Retroalimentación:
La hiperglucemia materna favorece hiperinsulinismo fetal y macrosomía.

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Lesión intraepitelial escamosa de alto grado

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 35 años con citología que reporta LIEAG (HSIL). Colposcopía muestra zona acetoblanca extensa con mosaico grueso. Biopsia confirma NIC III.

Pregunta 1

Conducta terapéutica recomendada:

A) Observación anual
B) Tratamiento escisional (LEEP o conización) *
C) Antibióticos
D) Histerectomía inmediata en todos los casos

Retroalimentación:
NIC III requiere tratamiento escisional para prevenir progresión a carcinoma invasor.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Ruptura prematura de membranas a término

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 25 años, primigesta, 39 semanas de gestación, acude por salida súbita de líquido claro abundante hace 3 horas. Niega fiebre, niega sangrado. Percibe movimientos fetales normales.

Exploración: TA 110/70 mmHg, FC 88 lpm, T 36.8°C. Abdomen con producto único, longitudinal, cefálico. FCF 145 lpm reactiva. Especuloscopía: salida de líquido claro por orificio cervical. Prueba de cristalización positiva. Cérvix posterior, 1 cm de dilatación, 30% borrado. Sin actividad uterina regular.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico?

A) Trabajo de parto activo
B) Ruptura prematura de membranas a término *
C) Amenaza de parto pretérmino
D) Incompetencia cervical

Retroalimentación:
Salida de líquido amniótico antes del inicio del trabajo de parto en embarazo ≥37 semanas corresponde a RPM a término.

Pregunta 2

Conducta inicial más adecuada:

A) Manejo expectante indefinido
B) Inducción del trabajo de parto *
C) Tocolíticos
D) Alta domiciliaria

Retroalimentación:
En RPM a término se recomienda inducir el trabajo de parto para disminuir riesgo de infección.

Tema: Parto pretérmino

Subtema: Amenaza de parto pretérmino

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 29 años, G2P1, 32 semanas de gestación, acude por contracciones dolorosas cada 8 minutos desde hace 4 horas. Refiere sensación de presión pélvica. No salida de líquido.

Exploración: TA 115/75 mmHg. FCF 150 lpm. Tacto vaginal: dilatación 2 cm, borramiento 50%, membranas íntegras. USG: longitud cervical 20 mm.

Pregunta 1

Diagnóstico:

A) Trabajo de parto pretérmino establecido
B) Amenaza de parto pretérmino *
C) Incompetencia cervical
D) Falso trabajo de parto

Retroalimentación:
Hay actividad uterina y cambios cervicales leves antes de 37 semanas sin progresión franca.

Pregunta 2

Intervención farmacológica para maduración pulmonar fetal:

A) Sulfato de magnesio
B) Betametasona *
C) Oxitocina
D) Misoprostol

Retroalimentación:
Los corticosteroides antenatales reducen síndrome de dificultad respiratoria neonatal.

Pregunta 3

Objetivo principal del uso de tocolíticos en este contexto:

A) Evitar parto definitivamente
B) Ganar 48 horas para efecto de corticoides *
C) Suspender embarazo hasta término
D) Disminuir dolor materno

Retroalimentación:
El objetivo es retrasar el parto para permitir acción de esteroides.

Tema: Hemorragia obstétrica

Subtema: Retención de restos placentarios

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 34 años, 2 horas postparto eutócico, presenta sangrado persistente moderado pese a útero contraído y firme. Placenta aparentemente completa al momento de la expulsión. TA 100/65 mmHg, FC 105 lpm.

USG transabdominal: imagen ecogénica intrauterina compatible con restos placentarios.

Pregunta 1

Causa más probable de la hemorragia:

A) Atonía uterina
B) Laceración vaginal
C) Retención de restos placentarios *
D) Coagulopatía primaria

Retroalimentación:
Útero firme con sangrado persistente sugiere restos retenidos.

Pregunta 2

Manejo indicado:

A) Observación
B) Revisión uterina y evacuación instrumental *
C) Antibiótico exclusivo
D) Anticonceptivos

Retroalimentación:
Debe evacuarse el contenido retenido para controlar hemorragia.

Tema: Endometriosis

Subtema: Presentación clínica clásica

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 30 años, nulípara, refiere dismenorrea progresiva desde hace 3 años, dolor pélvico crónico y dispareunia profunda. Desea embarazo desde hace 2 años sin éxito. Exploración: dolor a la movilización uterina, nodularidad en fondo de saco posterior.

USG transvaginal: quiste ovárico izquierdo de 4 cm con contenido homogéneo en "vidrio esmerilado".

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Quiste funcional
B) Endometrioma ovárico *
C) Absceso tubo-ovárico
D) Mioma subseroso

Retroalimentación:
Imagen en vidrio esmerilado + dolor pélvico crónico es típica de endometriosis.

Pregunta 2

Estudio confirmatorio definitivo:

A) CA-125
B) Resonancia
C) Laparoscopía diagnóstica *
D) Biometría hemática

Retroalimentación:
La laparoscopía con visualización directa es estándar diagnóstico definitivo.

Tema: Climaterio

Subtema: Terapia hormonal de reemplazo

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 52 años, 2 años postmenopausia, presenta bochornos intensos, insomnio y deterioro importante en calidad de vida. No antecedentes personales de cáncer, trombosis o enfermedad hepática. IMC 26 kg/m^2.

Pregunta por tratamiento hormonal.

Pregunta 1

¿Es candidata potencial a terapia hormonal?

A) No, está contraindicada en todas
B) Sí, si no tiene contraindicaciones *
C) Solo si tiene osteoporosis
D) Solo si tiene menos de 45 años

Retroalimentación:
Puede indicarse en mujeres sintomáticas sin contraindicaciones y dentro de ventana terapéutica.

Pregunta 2

En paciente con útero intacto, el esquema debe incluir:

A) Solo estrógeno
B) Estrógeno + progestágeno *
C) Solo progesterona
D) Andrógenos

Retroalimentación:
El progestágeno previene hiperplasia endometrial inducida por estrógeno.

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Cáncer de ovario – presentación clínica

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 60 años, multipara, refiere distensión abdominal progresiva, saciedad temprana y pérdida de peso no intencionada desde hace 4 meses. Exploración: ascitis moderada, masa anexial derecha irregular de 8 cm. CA-125 elevado.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Miomatosis uterina
B) Cáncer epitelial de ovario *
C) Embarazo ectópico
D) Quiste funcional

Retroalimentación:
Masa anexial compleja + ascitis + CA-125 elevado en postmenopáusica es altamente sugestivo.

Pregunta 2

Estudio inicial para estadificación:

A) Radiografía simple
B) TAC abdominopélvica *
C) Histeroscopía
D) Colposcopía

Retroalimentación:
La tomografía permite evaluar extensión intraabdominal.

Tema: Hemorragias del primer trimestre

Subtema: Embarazo molar (Mola hidatidiforme completa)

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 19 años, G1P0, 11 semanas por FUM, acude por sangrado vaginal intermitente oscuro desde hace 5 días, acompañado de náusea y vómito intensos incapacitantes. Refiere sensación de crecimiento abdominal mayor al esperado para la edad gestacional.

Exploración: TA 140/90 mmHg, FC 96 lpm. Útero palpable a nivel de 16 semanas aproximadamente. No se auscultan latidos fetales con Doppler. Tacto vaginal: cérvix cerrado, sangrado escaso.

Laboratorios: BHCG 280,000 mUI/mL. USG transvaginal: imagen en “copos de nieve”, sin embrión visible.

Pregunta 1

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Aborto retenido
B) Embarazo molar completo *
C) Embarazo ectópico
D) Gestación múltiple

Retroalimentación:
BHCG muy elevada + útero mayor al esperado + imagen en copos de nieve sin embrión sugieren mola completa.

Pregunta 2

Tratamiento inicial indicado:

A) Legrado uterino evacuador por aspiración *
B) Oxitocina
C) Histerectomía obligatoria
D) Metotrexato inicial

Retroalimentación:
El manejo inicial es evacuación uterina mediante aspiración.

Pregunta 3

Seguimiento posterior imprescindible:

A) USG semanal
B) BHCG seriada hasta negativización *
C) Radiografía anual
D) Anticonceptivos de barrera exclusivamente

Retroalimentación:
El seguimiento con BHCG seriada detecta enfermedad trofoblástica persistente.

Tema: Patología hipertensiva del embarazo

Subtema: Síndrome HELLP

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 30 años, 34 semanas, con antecedente de preeclampsia diagnosticada hace 1 semana, acude por dolor intenso en epigastrio irradiado a hipocondrio derecho, náusea y malestar general.

Exploración: TA 165/110 mmHg. Edema ++. Reflejos aumentados.

Laboratorios: plaquetas 75,000; AST 220 U/L; LDH elevada; bilirrubina indirecta elevada; esquistocitos en frotis.

Pregunta 1

Diagnóstico:

A) Hepatitis aguda
B) Síndrome HELLP *
C) Gastritis
D) Colecistitis

Retroalimentación:
Hemólisis + enzimas hepáticas elevadas + trombocitopenia definen HELLP.

Pregunta 2

Conducta obstétrica:

A) Manejo expectante hasta término
B) Interrupción del embarazo tras estabilización *
C) Solo antihipertensivos
D) Alta

Retroalimentación:
HELLP es indicación de resolución una vez estabilizada la paciente.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Prolapso de cordón umbilical

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 27 años, 38 semanas, en trabajo de parto con 4 cm de dilatación. Durante exploración tras ruptura artificial de membranas se documenta descenso brusco de FCF a 80 lpm sostenidos. Al tacto se palpa estructura pulsátil en vagina por delante de la presentación cefálica.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Bradicardia fetal transitoria
B) Prolapso de cordón umbilical *
C) DPPNI
D) Ruptura uterina

Retroalimentación:
Palpación de cordón + bradicardia fetal sostenida es diagnóstico clínico.

Pregunta 2

Conducta inmediata:

A) Esperar recuperación espontánea
B) Cesárea urgente *
C) Tocolíticos
D) Antibióticos

Retroalimentación:
Es una emergencia obstétrica que requiere resolución inmediata.

Tema: Infecciones en el embarazo

Subtema: Bacteriuria asintomática

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 24 años, 18 semanas de gestación, sin síntomas urinarios. Urocultivo de control prenatal reporta 120,000 UFC/mL de E. coli. Sin fiebre, sin dolor lumbar.

Pregunta 1

Conducta correcta:

A) No tratar por ausencia de síntomas
B) Iniciar antibiótico seguro en embarazo *
C) Solo vigilancia
D) Repetir estudio en 1 mes sin tratamiento

Retroalimentación:
La bacteriuria asintomática en embarazo debe tratarse para prevenir pielonefritis.

Pregunta 2

Complicación si no se trata:

A) Diabetes gestacional
B) Pielonefritis *
C) Eclampsia
D) Placenta previa

Retroalimentación:
La progresión a pielonefritis es la complicación más relevante.

Tema: Miomatosis uterina

Subtema: Mioma submucoso y sangrado uterino anormal

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 38 años, G2P2, refiere menstruaciones abundantes y prolongadas desde hace 8 meses, con coágulos y anemia progresiva. Niega dolor pélvico importante.

Exploración: útero ligeramente aumentado de tamaño. USG: mioma submucoso de 3.5 cm protruyendo hacia cavidad endometrial.

Pregunta 1

Causa más probable del sangrado:

A) Adenomiosis
B) Mioma submucoso *
C) Embarazo ectópico
D) Endometriosis

Retroalimentación:
Los miomas submucosos se asocian con sangrado uterino anormal.

Pregunta 2

Tratamiento quirúrgico de elección si desea conservar fertilidad:

A) Histerectomía
B) Miomectomía histeroscópica *
C) Oclusión tubaria
D) Radioterapia

Retroalimentación:
La resección histeroscópica es ideal para miomas submucosos.

Tema: Cáncer cervicouterino

Subtema: Cáncer invasor estadio temprano

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 42 años con biopsia cervical que reporta carcinoma epidermoide invasor. Resonancia muestra lesión confinada al cuello uterino sin extensión parametrial.

Pregunta 1

Estadio clínico probable:

A) I *
B) II
C) III
D) IV

Retroalimentación:
Enfermedad limitada al cuello corresponde a estadio I.

Pregunta 2

Tratamiento estándar en estadio temprano:

A) Radioterapia exclusiva
B) Histerectomía radical con linfadenectomía *
C) Observación
D) Anticonceptivos

Retroalimentación:
El manejo quirúrgico es opción en estadios tempranos sin diseminación.

Tema: Control prenatal

Subtema: Cálculo de edad gestacional

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Paciente de 22 años, primigesta, acude a consulta de primera vez. Refiere FUM el 3 de marzo, con ciclos regulares de 28 días. No antecedentes relevantes. Niega sangrado o dolor. Exploración física normal. Solicita saber su fecha probable de parto.

La consulta se realiza el 10 de mayo del mismo año.

Pregunta 1

¿Qué método clínico se utiliza para calcular la fecha probable de parto?

A) Fórmula de Parkland
B) Fórmula de Naegele *
C) Índice de Bishop
D) Regla de Apgar

Retroalimentación:
La fórmula de Naegele es el método clásico para estimar FPP en ciclos regulares.

Pregunta 2

La fecha probable de parto aproximada sería:

A) 10 de diciembre
B) 10 de enero
C) 10 de diciembre del mismo año *
D) 3 de noviembre

Retroalimentación:
Se suman 7 días y se restan 3 meses a la FUM.

Tema: Puerperio

Subtema: Endometritis puerperal

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 30 años, 5 días postcesárea por sufrimiento fetal. Consulta por fiebre de 38.5°C, malestar general y dolor hipogástrico progresivo. Refiere loquios fétidos.

Exploración: TA 110/70 mmHg, FC 102 lpm. Útero doloroso a la palpación. Herida quirúrgica sin datos de infección superficial.

Laboratorios: leucocitosis con neutrofilia.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Infección urinaria
B) Endometritis puerperal *
C) Mastitis
D) Trombosis venosa profunda

Retroalimentación:
Fiebre + dolor uterino + loquios fétidos postcesárea es típico de endometritis.

Pregunta 2

Tratamiento inicial:

A) Amoxicilina oral
B) Esquema antibiótico IV de amplio espectro *
C) Antiinflamatorios
D) Alta domiciliaria

Retroalimentación:
Se requiere cobertura IV amplia por flora polimicrobiana.

Tema: Anticoncepción

Subtema: Anticoncepción de emergencia

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Paciente de 19 años acude 24 horas después de relación sexual sin protección. Ciclos regulares. No antecedentes trombóticos.

Pregunta 1

Método farmacológico más eficaz dentro de las primeras 72 horas:

A) Misoprostol
B) Levonorgestrel *
C) Metotrexato
D) Oxitocina

Retroalimentación:
Levonorgestrel es método hormonal de emergencia eficaz si se administra oportunamente.

Pregunta 2

Mecanismo principal:

A) Interrupción de embarazo implantado
B) Inhibición o retraso de la ovulación *
C) Destrucción del embrión
D) Contracción uterina

Retroalimentación:
Actúa principalmente inhibiendo o retrasando la ovulación.

Tema: Hemorragia obstétrica

Subtema: Inversión uterina

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 27 años, inmediatamente posterior al alumbramiento, presenta dolor intenso súbito, hemorragia abundante y colapso hemodinámico. Se observa masa rojiza protruyendo por vagina. Útero no palpable en abdomen.

TA 80/50 mmHg, FC 130 lpm.

Pregunta 1

Diagnóstico:

A) Atonía uterina
B) Inversión uterina *
C) Retención placentaria
D) Ruptura uterina

Retroalimentación:
Masa vaginal + ausencia de fondo uterino abdominal es clásica de inversión.

Pregunta 2

Manejo inmediato prioritario:

A) Histerectomía directa
B) Reposición manual inmediata del útero *
C) Antibióticos
D) Alta

Retroalimentación:
La reposición manual urgente es esencial antes de que se establezca edema severo.

Tema: Trastornos menstruales

Subtema: Amenorrea secundaria

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 25 años con ausencia de menstruación desde hace 4 meses. Ciclos previos regulares. Vida sexual activa sin anticoncepción. Niega galactorrea o síntomas tiroideos.

Exploración normal.

Pregunta 1

Primer estudio a solicitar:

A) Perfil tiroideo
B) Prolactina
C) Prueba de embarazo *
D) Ultrasonido transvaginal

Retroalimentación:
Siempre debe descartarse embarazo como primera causa de amenorrea secundaria.

Pregunta 2

Causa más frecuente de amenorrea secundaria:

A) Síndrome de Asherman
B) Embarazo *
C) Tumor hipofisario
D) Insuficiencia ovárica primaria

Retroalimentación:
El embarazo es la causa más común.

Tema: Infecciones ginecológicas

Subtema: Vaginosis bacteriana

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Paciente de 28 años consulta por flujo vaginal grisáceo con olor fétido tipo “pescado” que se intensifica después de relaciones sexuales. No prurito intenso. pH vaginal 5.5. Prueba de aminas positiva.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Candidiasis
B) Vaginosis bacteriana *
C) Tricomoniasis
D) EPI

Retroalimentación:
Flujo grisáceo + pH elevado + prueba de aminas positiva es diagnóstico clínico.

Pregunta 2

Tratamiento de elección:

A) Fluconazol
B) Metronidazol *
C) Ceftriaxona
D) Clindamicina tópica exclusivamente obligatoria

Retroalimentación:
Metronidazol es tratamiento estándar.

Tema: Embarazo ectópico

Subtema: Embarazo ectópico roto

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 31 años, G2P1A0, 8 semanas por FUM, acude a urgencias por dolor abdominal súbito, intenso, localizado en fosa iliaca derecha, acompañado de lipotimia. Refiere manchado vaginal escaso desde hace 2 días. No control prenatal.

Exploración: TA 85/55 mmHg, FC 122 lpm, palidez generalizada, diaforesis. Abdomen con dolor intenso a la palpación y datos de irritación peritoneal. Tacto vaginal: cérvix cerrado, dolor a la movilización cervical, fondo de saco posterior doloroso.

BHCG positiva. USG FAST con líquido libre abundante en cavidad abdominal.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Apendicitis perforada
B) Aborto incompleto
C) Embarazo ectópico roto *
D) Quiste ovárico complicado

Retroalimentación:
Dolor súbito + inestabilidad hemodinámica + líquido libre + embarazo temprano es clásico de ectópico roto.

Pregunta 2

Conducta inmediata:

A) Metotrexato
B) Observación
C) Laparotomía/laparoscopía urgente *
D) Repetir BHCG

Retroalimentación:
La inestabilidad hemodinámica contraindica manejo médico; requiere cirugía urgente.

Tema: Hemorragia obstétrica

Subtema: Ruptura uterina

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 36 años, G4P3, antecedente de cesárea segmentaria previa, en trabajo de parto con inducción mediante oxitocina. Presenta dolor abdominal súbito, intenso y persistente, seguido de pérdida de la dinámica uterina. FCF cae a 70 lpm. Se palpan fácilmente partes fetales a través del abdomen.

TA 90/60 mmHg, FC 118 lpm.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) DPPNI
B) Ruptura uterina *
C) Prolapso de cordón
D) Atonía uterina

Retroalimentación:
Antecedente de cesárea + dolor súbito + pérdida de dinámica + bradicardia fetal sugieren ruptura uterina.

Pregunta 2

Manejo inmediato:

A) Incrementar oxitocina
B) Cesárea/laparotomía urgente *
C) Tocolíticos
D) Observación

Retroalimentación:
Es emergencia quirúrgica materno-fetal.

Tema: Control prenatal

Subtema: Pruebas de laboratorio iniciales

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Paciente de 20 años, 10 semanas de gestación, acude a su primera consulta prenatal. Sin antecedentes patológicos. No síntomas actuales.

Pregunta 1

¿Cuál de los siguientes estudios forma parte del tamizaje inicial obligatorio?

A) TAC abdominopélvica
B) Grupo sanguíneo y Rh *
C) Resonancia magnética
D) CA-125

Retroalimentación:
Determinación de grupo y Rh es fundamental para prevención de isoinmunización.

Pregunta 2

Si la paciente es Rh negativo y la pareja Rh positivo, debe:

A) No hacer nada
B) Aplicar inmunoglobulina anti-D según protocolo *
C) Inducir parto temprano
D) Suspender embarazo

Retroalimentación:
La profilaxis anti-D previene enfermedad hemolítica perinatal.

Tema: Trastornos hipertensivos

Subtema: Hipertensión gestacional

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 28 años, 37 semanas, sin antecedentes, presenta TA 145/95 mmHg en dos ocasiones separadas por 4 horas. Niega cefalea, fosfenos o dolor epigástrico. Proteinuria negativa. Laboratorios normales.

Pregunta 1

Diagnóstico:

A) Preeclampsia
B) Hipertensión gestacional *
C) Eclampsia
D) HELLP

Retroalimentación:
HTA posterior a 20 semanas sin proteinuria ni datos de severidad corresponde a hipertensión gestacional.

Pregunta 2

Conducta a las 37 semanas:

A) Continuar embarazo hasta 41 semanas
B) Interrumpir embarazo *
C) Tocolíticos
D) Solo dieta

Retroalimentación:
A término se recomienda resolución obstétrica.

Tema: Patología mamaria

Subtema: Mastitis puerperal

Dificultad: Media

Caso clínico:

Puérpera de 3 semanas, lactando, consulta por dolor en mama izquierda, eritema localizado, fiebre de 38.2°C y malestar general. Refiere grietas en pezón.

Exploración: zona eritematosa caliente y dolorosa, sin fluctuación evidente.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Absceso mamario
B) Mastitis puerperal *
C) Cáncer inflamatorio
D) Galactocele

Retroalimentación:
Cuadro infeccioso localizado sin colección definida sugiere mastitis.

Pregunta 2

Conducta adecuada:

A) Suspender lactancia
B) Antibiótico y continuar lactancia *
C) Drenaje quirúrgico inmediato
D) Observación

Retroalimentación:
Debe continuarse lactancia y administrar antibiótico adecuado.

Tema: Trastornos menstruales

Subtema: Dismenorrea primaria

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Adolescente de 16 años, ciclos regulares desde los 13 años, presenta dolor tipo cólico intenso durante los primeros 2 días de menstruación, sin síntomas intermenstruales. Exploración normal.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Endometriosis
B) Dismenorrea primaria *
C) EPI
D) Miomatosis

Retroalimentación:
Dolor menstrual en adolescente sin patología estructural sugiere dismenorrea primaria.

Pregunta 2

Tratamiento inicial de elección:

A) Antibióticos
B) AINEs *
C) Cirugía
D) Anticonvulsivos

Retroalimentación:
Los AINEs inhiben prostaglandinas, mecanismo fisiopatológico principal.

Tema: Hemorragias del tercer trimestre

Subtema: Vasa previa

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 33 años, G2P1, 38 semanas, en trabajo de parto inicial con 3 cm de dilatación. Durante la ruptura artificial de membranas se observa salida de líquido amniótico claro seguida de sangrado vaginal rojo brillante en pequeña cantidad. Inmediatamente se documenta bradicardia fetal sostenida de 70 lpm. La paciente permanece hemodinámicamente estable, sin dolor uterino ni hipertonía.

USG previo reportaba inserción velamentosa del cordón.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Placenta previa
B) DPPNI
C) Vasa previa *
D) Ruptura uterina

Retroalimentación:
Sangrado tras ruptura de membranas + bradicardia fetal súbita + madre estable sugieren ruptura de vasos fetales.

Pregunta 2

Conducta inmediata:

A) Observación
B) Cesárea urgente *
C) Oxitocina
D) Tocolíticos

Retroalimentación:
Es emergencia fetal; requiere resolución inmediata.

Tema: Patología hipertensiva del embarazo

Subtema: Profilaxis con ácido acetilsalicílico

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Paciente de 36 años, G2P1, 12 semanas de gestación. Antecedente de preeclampsia en embarazo previo con parto a las 35 semanas. IMC 30 kg/m^2. TA actual 110/70 mmHg.

Pregunta 1

¿Es candidata a profilaxis para preeclampsia?

A) No, porque está normotensa
B) Sí, por antecedente de alto riesgo *
C) Solo después de 20 semanas
D) Solo si tiene proteinuria

Retroalimentación:
Antecedente de preeclampsia es factor de alto riesgo; debe indicarse profilaxis.

Pregunta 2

Fármaco recomendado:

A) Heparina
B) Ácido acetilsalicílico en dosis baja *
C) Metildopa
D) Nifedipino

Retroalimentación:
AAS en baja dosis reduce riesgo de recurrencia.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Índice de Bishop

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 29 años, 41 semanas, candidata a inducción por embarazo prolongado. Tacto vaginal: dilatación 1 cm, borramiento 40%, consistencia cervical firme, posición posterior, presentación cefálica en estación -2.

Pregunta 1

¿Qué evalúa el índice de Bishop?

A) Bienestar fetal
B) Madurez cervical para inducción *
C) Tamaño fetal
D) Riesgo hemorrágico

Retroalimentación:
El Bishop valora condiciones cervicales para éxito de inducción.

Pregunta 2

Con estas características, el Bishop es probablemente:

A) Favorable
B) Desfavorable *
C) Óptimo
D) Innecesario calcular

Retroalimentación:
Cérvix poco dilatado, firme y posterior indica bajo puntaje.

Tema: Diabetes gestacional

Subtema: Tratamiento inicial

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 30 años, 28 semanas, diagnosticada con diabetes gestacional mediante curva confirmatoria. Glucosas en ayuno repetidas entre 92–95 mg/dL y posprandiales ligeramente elevadas.

Pregunta 1

Primera medida terapéutica:

A) Insulina inmediata
B) Plan nutricional y ejercicio *
C) Metformina obligatoria
D) Hospitalización

Retroalimentación:
El manejo inicial es dieta y ejercicio, con monitoreo.

Pregunta 2

Si no se alcanzan metas glucémicas con dieta:

A) Suspender seguimiento
B) Iniciar insulina *
C) Antibióticos
D) Sulfonilureas como primera línea obligatoria

Retroalimentación:
La insulina es tratamiento farmacológico de elección si falla manejo dietético.

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Cáncer de mama – factores de riesgo

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Paciente de 48 años, nulípara, menarquia a los 11 años, sin embarazos. Madre con cáncer de mama diagnosticado a los 50 años. Consulta por mastografía de rutina.

Pregunta 1

Factor de riesgo presente en esta paciente:

A) Multiparidad
B) Nuliparidad *
C) Lactancia prolongada
D) Menopausia temprana

Retroalimentación:
Nuliparidad y menarquia temprana aumentan riesgo por mayor exposición estrogénica.

Pregunta 2

Edad recomendada para mastografía de tamizaje en población general:

A) Desde los 20 años
B) Desde los 30 años
C) Desde los 40 años *
D) Solo si hay síntomas

Retroalimentación:
El tamizaje inicia a los 40 años en población general.

Tema: Puerperio

Subtema: Trombosis venosa profunda

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 35 años, 7 días postcesárea, obesidad IMC 34 kg/m^2, refiere dolor y aumento de volumen en pantorrilla izquierda. No fiebre. Exploración: edema unilateral, dolor a la palpación profunda, aumento de temperatura local.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Celulitis
B) Trombosis venosa profunda *
C) Contractura muscular
D) Linfedema crónico

Retroalimentación:
Puerperio + cirugía + obesidad son factores de riesgo claros.

Pregunta 2

Estudio diagnóstico inicial:

A) Radiografía
B) Ultrasonido Doppler venoso *
C) Resonancia
D) D-dímero exclusivamente

Retroalimentación:
El Doppler es estudio de elección.

Pregunta 3

Tratamiento indicado:

A) AINEs
B) Anticoagulación con heparina de bajo peso molecular *
C) Antibióticos
D) Reposo sin fármacos

Retroalimentación:
HBPM es tratamiento estándar en embarazo y puerperio.

Tema: Hemorragia obstétrica

Subtema: Coagulación intravascular diseminada (CID) secundaria a DPPNI

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 32 años, 36 semanas, antecedente de hipertensión gestacional, acude por dolor abdominal súbito intenso y sangrado transvaginal oscuro moderado. Se documenta DPPNI clínico. Se realiza cesárea urgente por sufrimiento fetal.

Durante el transoperatorio presenta sangrado difuso incoercible por sitios de incisión y punción venosa. TA 90/60 mmHg, FC 120 lpm.

Laboratorios: plaquetas 45,000; TP y TTPa prolongados; fibrinógeno disminuido; dímero D elevado.

Pregunta 1

Complicación hematológica más probable:

A) Púrpura trombocitopénica
B) CID *
C) Hemofilia adquirida
D) Trombocitopenia gestacional

Retroalimentación:
El DPPNI es causa clásica de CID obstétrica.

Pregunta 2

Manejo inicial prioritario:

A) Solo oxitocina
B) Reposición con hemoderivados según déficit *
C) Anticoagulación inmediata
D) Alta

Retroalimentación:
Se requiere reposición dirigida (plasma, plaquetas, crioprecipitado) además de control de la causa.

Tema: Embarazo múltiple

Subtema: Síndrome de transfusión feto-fetal

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 27 años, embarazo gemelar monocorial biamniótico de 24 semanas. USG reporta discrepancia significativa en líquido amniótico: un feto con oligohidramnios severo y otro con polihidramnios marcado. Diferencia de peso estimado >25%.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Restricción selectiva de crecimiento
B) Síndrome de transfusión feto-fetal *
C) Diabetes gestacional
D) Placenta previa

Retroalimentación:
En embarazos monocoriales, discordancia de líquido es característica.

Pregunta 2

Tratamiento de elección en casos severos:

A) Reposo
B) Fotocoagulación láser de anastomosis placentarias *
C) Cesárea inmediata
D) Tocolíticos

Retroalimentación:
La corrección láser de las anastomosis es tratamiento definitivo.

Tema: Trastornos menstruales

Subtema: Sangrado uterino anormal anovulatorio

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 17 años, menarquia a los 12, ciclos irregulares desde entonces. Presenta episodios de sangrado abundante prolongado, sin dolor pélvico. USG normal. Hb 10 g/dL.

Pregunta 1

Causa más probable en esta etapa de la vida:

A) Mioma
B) Anovulación por inmadurez eje HHO *
C) Cáncer endometrial
D) Endometriosis

Retroalimentación:
En adolescentes, la causa más frecuente es anovulación por inmadurez endocrina.

Pregunta 2

Tratamiento médico inicial:

A) Antibióticos
B) Anticonceptivos hormonales combinados *
C) Cirugía
D) Radioterapia

Retroalimentación:
Los ACO regulan ciclo y controlan sangrado.

Tema: Climaterio

Subtema: Osteoporosis postmenopáusica

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 58 años, 6 años postmenopausia, sin terapia hormonal, IMC 21 kg/m^2. Antecedente materno de fractura de cadera. Se realiza densitometría ósea con T-score de -2.7 en cuello femoral.

Pregunta 1

Diagnóstico densitométrico:

A) Osteopenia
B) Osteoporosis *
C) Normal
D) Osteomalacia

Retroalimentación:
T-score ≤ -2.5 define osteoporosis.

Pregunta 2

Tratamiento farmacológico de primera línea:

A) Calcio exclusivamente
B) Bifosfonatos *
C) Antibióticos
D) Progesterona sola

Retroalimentación:
Bifosfonatos reducen riesgo de fractura.

Tema: Infecciones ginecológicas

Subtema: Tricomoniasis

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Paciente de 24 años con flujo vaginal abundante amarillo-verdoso espumoso, prurito y dispareunia. pH vaginal 6.0. Cérvix con aspecto en “fresa”.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Candidiasis
B) Vaginosis bacteriana
C) Tricomoniasis *
D) EPI

Retroalimentación:
Flujo espumoso + cérvix en fresa es clásico de Trichomonas.

Pregunta 2

Tratamiento indicado:

A) Fluconazol
B) Metronidazol *
C) Ceftriaxona
D) Doxiciclina

Retroalimentación:
Metronidazol es tratamiento de elección y debe tratarse la pareja.

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Hiperplasia endometrial sin atipia

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 45 años, obesa, con ciclos irregulares y sangrado uterino abundante. Biopsia endometrial reporta hiperplasia simple sin atipia.

Pregunta 1

Factor fisiopatológico principal:

A) Déficit estrogénico
B) Exposición estrogénica sin oposición *
C) Infección crónica
D) Trauma uterino

Retroalimentación:
Anovulación crónica produce estimulación estrogénica persistente.

Pregunta 2

Tratamiento médico indicado:

A) Estrógenos
B) Progestágenos *
C) Radioterapia
D) Histerectomía obligatoria

Retroalimentación:
Los progestágenos revierten hiperplasia sin atipia.

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Desproporción cefalopélvica

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 24 años, primigesta, 40 semanas, en trabajo de parto desde hace 10 horas. Membranas rotas hace 6 horas. Dinámica uterina adecuada (4–5 contracciones en 10 minutos, intensidad adecuada). Dilatación estacionada en 8 cm durante 4 horas. Presentación cefálica en estación -1. Pelvis clínica aparentemente límite. FCF 140 lpm, reactiva.

No hay datos de sufrimiento fetal, pero no existe progresión del descenso a pesar de adecuada actividad uterina documentada.

Pregunta 1

Diagnóstico obstétrico más probable:

A) Hipodinamia uterina
B) Desproporción cefalopélvica *
C) Fase latente prolongada
D) Prolapso de cordón

Retroalimentación:
Ausencia de progresión con dinámica adecuada sugiere desproporción.

Pregunta 2

Conducta más adecuada:

A) Aumentar oxitocina indefinidamente
B) Cesárea *
C) Tocolíticos
D) Observación 12 horas más

Retroalimentación:
Arresto de dilatación con dinámica adecuada indica resolución quirúrgica.

Tema: Hemorragias del primer trimestre

Subtema: Aborto diferido (retenido)

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 29 años, 10 semanas por FUM, refiere desaparición de síntomas de embarazo y leve manchado marrón intermitente. Niega dolor. Exploración: cérvix cerrado. USG transvaginal muestra embrión sin actividad cardiaca acorde a 8 semanas.

BHCG menor a la esperada para edad gestacional.

Pregunta 1

Diagnóstico:

A) Amenaza de aborto
B) Aborto incompleto
C) Aborto diferido *
D) Embarazo ectópico

Retroalimentación:
Muerte embrionaria sin expulsión del producto con cérvix cerrado corresponde a aborto diferido.

Pregunta 2

Opciones de manejo válidas:

A) Solo observación obligatoria
B) Manejo médico o evacuación uterina según caso *
C) Antibióticos
D) Histerectomía

Retroalimentación:
Puede optarse por manejo expectante, médico o quirúrgico según condiciones clínicas.

Tema: Infecciones en el embarazo

Subtema: Pielonefritis aguda gestacional

Dificultad: Alta

Caso clínico:

Paciente de 26 años, 24 semanas, acude por fiebre de 39°C, dolor lumbar derecho intenso y náusea. Refiere disuria previa no tratada. Exploración: dolor a puño-percusión lumbar derecha. TA 100/65 mmHg, FC 110 lpm.

EGO: bacteriuria, leucocituria. Leucocitosis en BH.

Pregunta 1

Diagnóstico más probable:

A) Lumbalgia mecánica
B) Pielonefritis aguda *
C) Cistitis simple
D) Apendicitis

Retroalimentación:
Fiebre alta + dolor lumbar + datos urinarios es diagnóstico clínico de pielonefritis.

Pregunta 2

Manejo inicial:

A) Tratamiento ambulatorio
B) Hospitalización y antibiótico IV *
C) Solo analgésicos
D) Alta

Retroalimentación:
En embarazo requiere manejo intrahospitalario por riesgo de complicaciones.

Pregunta 3

Complicación obstétrica asociada:

A) Placenta previa
B) Parto pretérmino *
C) Miomatosis
D) Mola

Retroalimentación:
Infección sistémica aumenta riesgo de parto pretérmino.

Tema: Anticoncepción

Subtema: DIU hormonal (levonorgestrel)

Dificultad: Media

Caso clínico:

Paciente de 34 años, G2P2, con sangrado menstrual abundante y deseo anticonceptivo a largo plazo. No factores de riesgo trombótico. Hb 11 g/dL.

Pregunta 1

Ventaja adicional del DIU hormonal frente al de cobre:

A) Aumenta sangrado
B) Disminuye sangrado menstrual *
C) Inhibe ovulación en todas
D) Produce menopausia

Retroalimentación:
El levonorgestrel produce atrofia endometrial y reduce sangrado.

Pregunta 2

Duración aproximada de eficacia:

A) 6 meses
B) 1 año
C) 5 años aproximadamente *
D) 10 años obligatorios

Retroalimentación:
La mayoría de sistemas liberadores duran alrededor de 5 años.

Tema: Patología mamaria

Subtema: Absceso mamario

Dificultad: Media

Caso clínico:

Puérpera de 4 semanas con antecedente reciente de mastitis tratada parcialmente. Consulta por dolor intenso localizado en mama derecha, fiebre persistente y ahora presencia de zona fluctuante de 3 cm.

Pregunta 1

Diagnóstico:

A) Mastitis simple
B) Absceso mamario *
C) Galactocele
D) Cáncer inflamatorio

Retroalimentación:
La presencia de fluctuación indica colección purulenta.

Pregunta 2

Manejo indicado:

A) Solo antibióticos
B) Drenaje + antibióticos *
C) Suspender lactancia obligatoriamente
D) Observación

Retroalimentación:
El absceso requiere drenaje además de antibiótico.

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Cáncer de endometrio – síntoma de alarma

Dificultad: Fácil

Caso clínico:

Paciente de 62 años, 12 años postmenopausia, consulta por sangrado vaginal escaso intermitente desde hace 2 semanas. IMC 32 kg/m^2. No terapia hormonal.

Pregunta 1

Síntoma de alarma principal:

A) Dolor pélvico
B) Sangrado postmenopáusico *
C) Leucorrea
D) Disuria

Retroalimentación:
Todo sangrado postmenopáusico debe estudiarse por posible cáncer endometrial.

Pregunta 2

Estudio inicial recomendado:

A) Colposcopía
B) Ultrasonido transvaginal para medir grosor endometrial *
C) TAC
D) CA-125

Retroalimentación:
El USG transvaginal es primer paso para valorar endometrio.